

或抑郁情绪。

从生物学角度来看，当淀粉样前体蛋白（amyloid precursor protein, APP）[\(28\)](#)的产生出现异常时，细胞就会大量结块，从而引发神经元发炎和变质。接下来，大脑会慢慢萎缩，海马和额叶、颞叶的一些区域开始退化。另外，一些特定神经元的死亡，会导致乙酰胆碱（ach）等很多神经递质短缺（Medeiros et al., 2007; Bredesen, 2009; Callahan et al., 2013）。

尽管我们已经知道导致阿尔茨海默病的大脑生理变化，但最初究竟是什么原因触发了这一问题，至今仍是个谜。很显然，遗传因素在这一过程中起到了作用，一些家族罹患阿尔茨海默病的概率要高于其他家族。实际上，某些家族可能有一半的孩子从父母那里遗传了这种疾病。另外，研究者通过研究大量的大脑扫描图发现（见图9-5），在阿尔茨海默病症状出现之前的许多年，有遗传患病风险的个体在回忆信息时，其脑功能就已经与其他人不同了（Thomas & Fenech, 2007; Baulac et al., 2009; Désirée et al., 2013）。

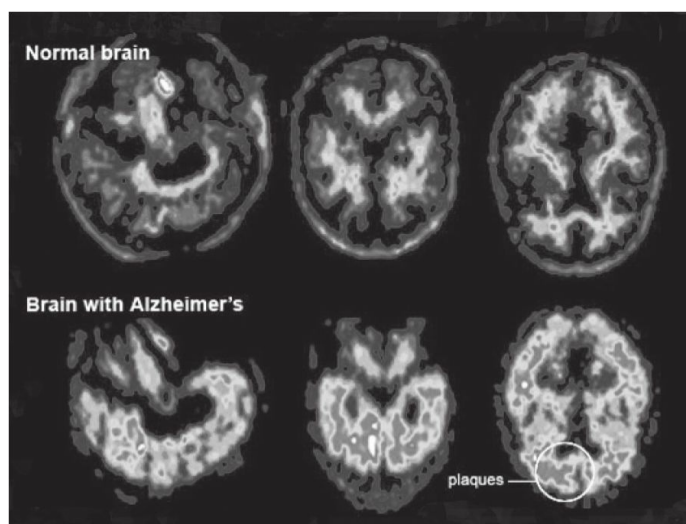


图9-5 患者和非患者的大脑有所不同吗

脑部扫描显示，阿尔茨海默病患者（下）与非患者（上）的大脑存在差异。

资料来源：Bookheimer et al., 2000.

大量证据表明，阿尔茨海默病是一种遗传疾病，但是高血压或不良饮食等非遗传因素可能会增加人们罹患此病的概率。一项跨文化研究显示，居住在尼日利亚一个镇上的穷困黑人患上阿尔茨海默病的概率比情况相当的非裔美国居民更低。研究者推断，这两组人群在饮食上的差异也许可以解释阿尔茨海默病患病率的不同，因为尼日利亚的居民主要吃蔬菜，这样更健康（Hendrie et al., 2001; Chen et al., 2010; Fuso et al., 2012; Roussotte et al., 2014）。

研究者也在研究可能引起该疾病的其他原因，如病毒感染、免疫功能紊乱和激素分泌不平衡等。还有研究发现，20岁早期较低水平的语言能力会加速晚年时期由阿尔茨海默病引起的认知能力退化（Snowdon et al., 1996; Alisky, 2007; Carbone et al., 2014）。

目前阿尔茨海默病还无法治愈，只能通过治疗缓解一些症状。某些类型的阿尔茨海默病会出现神经递质乙酰胆碱损失的情况，最有效的药物都与此有关。盐酸多内济尔[donepezil，商品名是艾里赛特（Aricept）]、加兰他敏[galantamine，商品名亦是加兰他敏（Razadyne）]、重酒石酸卡巴拉汀[rivastigmine，商品名是艾斯能（Exelon）]、他克林[tacrine，商品名是益智胶囊（Cognex）]都是最常用的处方药，但是只对50%的阿尔茨海默病患者有效，而且其疗效只是暂时的（de Jesus Moreno, 2003; Gauthier & Scheltens, 2009）。

其他包括消炎药在内的正处于研究阶段的药物，都旨在减轻阿尔茨海默病患者的大脑炎症。另外，由于已有证据表明服用维生素C和维生素E的人罹患该病的风险更低，所以研究者正在对此类维生素的化学成分进行试验（Alzheimer's Association, 2004; Mohajeri & Leuba, 2009; Sabbagh, 2009）。

阿尔茨海默病患者会失去自主饮食和穿衣的能力，甚至不能控制大小便，所以他们全天24小时都要被看护。因此，大多数阿尔茨海默病患者是在护理院走完生命最后一程的，他们约占护理院患者人数的

2/3（Prigerson, 2003; Sparks, 2008）。

看护阿尔茨海默病患者的人常被称为该疾病的间接受害者，因为他们很容易由于疲于或无法应对患者极高的需求而感到受挫、愤怒和筋疲力尽（见“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏）。如果看护者是患者的家属，那他不仅要付出繁重的体力劳动以照顾周全，还要眼睁睁地看着所爱的人身体不断恶化、情绪持续波动甚至突然发狂，直至离开人世（Thomas et al., 2006; Ott, Sanders, & Kelber, 2007; Sanders et al., 2008）。

成为发展心理学知识的明智运用者 照料阿尔茨海默病患者

照料阿尔茨海默病患者是疾病看护中最难的工作之一，不过有些办法可以帮助阿尔茨海默病患者和看护者。

- 让患者花尽可能长的时间来完成一些日常生活事项，以使他们感到家是很安全的地方。
- 在日常用品上贴相应的标签，为患者提供日历、详细且简明的清单，口头提醒他们有关事件的时间和地点。
- 让穿衣服变得简单起来：为患者准备的衣服尽量不要有拉链和纽扣，把衣服按穿在身上的顺序摆放好。
- 安排好洗澡的日程。阿尔茨海默病患者可能会因为害怕摔倒和水太烫而拒绝洗澡，所以看护者要为其设定相应的洗澡日程。
- 不要让患者开车。患者常常希望像以前一样继续开车，但他们发生事故的概率很高，几乎是一般人的20倍。
- 监控患者的电话使用情况。阿尔茨海默病患者在应答电话时，可能会同意电话推销员和投资咨询者的请求。
- 给患者提供锻炼的机会，如每日散步。这能够阻止肌肉退化和僵硬。
- 看护者要记得为自己抽出部分时间，以平衡自己的生活，比如可以向社区服务组织寻求帮助。



传奇篮球教练帕特·萨米特于64岁离开人世，此前她经受了5年阿尔茨海默病的折磨。

成年晚期的健康：衰老与疾病之间的关系 生病并不是老年期不可避免的事情。相对于年龄因素，老年人是否生病更多地取决于许多其他因素，包括遗传的易患病体质、过去和现在的环境因素以及心理因素。

首先，遗传和环境因素会影响患病概率。一些如癌症和心脏病这样的疾病显然有遗传的成分，但有家族遗传史并不意味着一个人一定会罹患某种疾病。是否吸烟、饮食的特点、是否被长时间曝晒或接触石棉等致癌物质，这些生活方式都可能提高或降低人们患此类疾病的概率。

其次，经济水平也会起到一定作用。例如，在生命的任何阶段，贫困都会影响人们享受医疗卫生服务的水平。甚至经济条件较好的人，也很难找到负担得起的医疗卫生服务。例如，2013年退休的普通65岁老人

到他生命结束所需要的医疗费用约为22万美元。另外，老年人用于医疗保健的费用占到了总开销的13%，是年轻个体的2倍多（Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2010; Wild et al., 2014）。

最后，心理因素对老年人患病的可能性也有重要影响。例如，对居住环境有控制感或拥有对日常事务进行选择的权利，都可以让人拥有更好的心理状态和健康状况（Levy, Slade, & Kasl, 2002; Taylor, 2014）。

想要改善身体健康状况、延年益寿，老年人只要做一些每个年龄段都应该做的事情就可以了，比如合理饮食、锻炼身体，同时避免吸烟等明显危害健康的行为。现在，医疗和社会服务专业人士的目标是拓展老年人的积极寿命，即延长他们能够保持健康、享受生活的时间（Sawatzky & Naimark, 2002; Gavin & Myers, 2003; Katz & Marshall, 2003）。



饮食对衰老和疾病来说都是重要的影响因素。

不过有时候，老年人甚至没有条件遵从这些简单的原则。例如，粗略的估计显示，15%~50%的老年人存在营养不良的情况，数百万的老年人每天遭受着饥饿（Strohl, Bednar, & Longley, 2012; Giacalone et al.,

2016)。

造成营养不良和饥饿的原因有很多。一些老年人是因为太穷而买不起足够的食物，一些老年人则是因为身体太虚弱而无法自己购物或煮饭，还有一些老年人没有动力做饭或进食，尤其是当他们独居或抑郁时。对那些味觉和嗅觉敏感性下降的老人来说，进食可能已不再是一种享受了。而且，一些老年人可能年轻时膳食就不太均衡（Wolfe, Olson, & Kendall, 1998）。

充分锻炼对老年人来说可能也有一定的困难。疾病或恶劣的天气都会成为他们锻炼的障碍，甚至有时他们会面临双重难题，例如一个没有钱吃饱饭的穷人可能也没有体力进行锻炼（Kamijo et al., 2009; Kelley et al., 2009; Logsdon et al., 2009）。

成年晚期的性：用进废退 你的祖父母有性生活吗？

非常可能的答案是：有。越来越多的证据表明，个体到了八九十岁仍会在性方面十分活跃。尽管流行的刻板印象会让我们觉得两个75岁的老年人发生性行为不太合适，而一个75岁老人手淫似乎更奇怪。但在许多文化中，人们会期望老年人在性方面保持活跃；在一些社会中，人们还预期个体会随着年龄的增长而在性方面更放得开（Hillman, 2000; Lindau et al., 2007）。

两个主要因素决定了老年人是否还有性生活。一个是身体和心理状态，另一个则是先前的性生活是否规律。“用进废退”似乎能准确描述老年人的性能力。性生活能够而且通常是贯穿一生的。此外，一些有意思的证据表明，进行性生活还可能会有意外之喜——规律的性生活往往能延年益寿（Masters, Johnson, & Kolodny, 1982; Huang et al., 2009; Hillman, 2012; McCarthy & Pierpaoli, 2015）！

一项调查发现，70岁以上的老年人中有43%的男性和33%的女性手淫，而手淫的平均频率是每周一次。大约2/3的已婚男性及女性与配偶

发生性关系的频率也是每周一次。另外，认为自己的性伴侣外表有吸引力的人所占比例也在随着年龄的增长而增加（Araujo, Mohr, & McKinlay, 2004; Ravanipour, Gharibi, & Gharibi, 2013）。

当然，衰老确实让性功能出现了一些变化。从接近50岁至70岁出头的这段时间内，男性睾丸激素下降的平均幅度为30%~40%。男性勃起渐渐需要更长的时间和更多的刺激。不应期阶段，即男性在性高潮后不能再次被唤起的时间可能会持续一天甚至几天。女性的变化则是阴道变窄、失去弹性，自然分泌的润滑液变少了，这都使性交变得更加困难。需要注意的是，老年人像年轻人一样，也容易染上性病。事实上，在被诊断为艾滋病的患者中，有10%的人超过50岁，而在其他性传播疾病的新患者群中，50岁以上的人也是所有年龄段里所占比例最高的（Seidman, 2003; National Institute of Aging, 2004）。

衰老的理论：死亡为什么不可避免

学习目标**9.5** 探讨有关衰老的不同理论，并总结有关延长预期寿命的研究。

死亡的阴影始终笼罩着成年晚期的人们。我们会在某个时刻意识到，无论在生命的各个阶段有多么健康，我们都会经历身体的衰老并走向死亡。这是为什么呢？

主要有两种理论可以解释我们为什么会经历身体的衰老和死亡：衰老的遗传预程理论和衰老的磨损理论。

衰老的遗传预程理论（**genetic programming theories of aging**）认为，人体DNA遗传密码包含了细胞繁殖的内置时间限制。当生命所历经的时间超过由遗传决定的那段时间之后，细胞就不能再分裂了，个体从此开始走向衰老（Rattan, Kristensen, & Clark, 2006）。

遗传预程理论有几个变式。一个是认为遗传物质包含了“死亡基

因”，它向身体发出走向衰老和死亡的指令。持进化论观点的研究者则认为，个体在繁殖期之后已无必要为了物种的生存而延长寿命。这种观点指出，那些更容易在生命晚期侵袭人类的遗传疾病将会持续存在，因为这些疾病并没有妨碍人们繁殖后代，却同时将引起疾病和死亡的预置基因传递了下去。

遗传预程理论的另一个变式认为，身体细胞可以复制的次数是固定的。在整个生命过程中，新的细胞通过细胞复制产生，以修复和补充全身各组织器官的细胞。这种观点指出，负责身体运转的遗传指令所能被读取的次数是固定的，之后它就会变得难以辨认，进而细胞就停止繁殖。身体因为不再像以前那样稳步更新，就会渐渐开始衰退，最终导致个体的死亡（Thoms, Kuschal, & Emmert, 2007）。

支持遗传预程理论的研究表明，在实验中，一个人体细胞只能成功分裂50次左右。细胞每分裂一次，染色体的端粒（telomeres），即位于染色体末端的一小段DNA保护区域就会变得短些。当染色体的端粒消失时，细胞就停止复制。不再更新的细胞会更容易被损坏，并使个体产生衰老的迹象（Chung et al., 2007; Epel, 2009; Kolyada et al., 2016）。



衰老的遗传预编程理论指出，人体DNA遗传密码包含了生命长度的内置时间限制。

另一种解释衰老和身体退化的理论是衰老的磨损理论（**wear-and-tear theories of aging**），该理论认为身体的各项机能是被磨损殆尽的，就像汽车和洗衣机一样。一些支持磨损理论的研究者指出，为了能进行各种活动，身体会不断制造能量，同时生成副产品。这些副产品（或称毒素）与日常生活中面临的诸如辐射、化学品、意外事故和疾病等各种威胁共同作用，累积到较大量后就会破坏身体的正常功能，最终造成身体机能的衰退和死亡。

这些副产品中与衰老有关的一类特殊物质是自由基（**free radicals**），它是由人体细胞产生的带电分子或原子。因为带电，所以自由基可能会到处抢夺人体细胞中的电子而对细胞产生不利影响。大量研究表明，氧自由基可能是造成癌症、心脏病、糖尿病等许多与年龄相关的疾病的原因之一（Sierra, 2006; Hayflick, 2007; Sonnen et al., 2009）。

协调各种衰老理论 遗传预程理论和磨损理论对死亡的必然性做出了不同解释。遗传预程理论认为，生命由基因预设了一个固定的时间限制；磨损理论尤其是那些主张毒素的逐渐累积是导致死亡的原因之一理论，则代表更乐观的立场。这种理论认为，如果能够找到一种消除身体产生的和由于接触环境而产生的毒素的方法，那么就有可能延缓个体的衰老。例如，某些基因似乎可以延缓衰老，并增强个体抵抗与年龄相关的疾病的能力（Ghazi, Henis-Korenblit, & Kenyon, 2009）。我们不知道哪种理论更准确，不过它们都得到了一些研究结果的支持，而且似乎也都能解释衰老的某些方面。不过说到底，衰老仍然是一个未解之谜（Horiuchi, Finch, & Mesle, 2003; Friedman & Janssen, 2010; Aldwin & Igarashi, 2015）。

预期寿命：我能活多久 我们虽然并不完全清楚个体死亡的原因，但可以知道人的平均寿命，即大多数人能够活到老年。预期寿命（**life expectancy**）是指一个群体中成员死亡的平均年龄，例如出生在2012年的人，其预期寿命为79岁。

自有记录以来，人类的预期寿命一直在稳定地增加（见图9-6）。在美国，1776年人们的预期寿命只有35岁，到了20世纪初，预期寿命就增加到了47岁。在1950—1990年的40年间，人们的预期寿命从68岁增加到了75岁以上。可以预测，人们的预期寿命还会继续增加，到2050年可能会达到80岁。

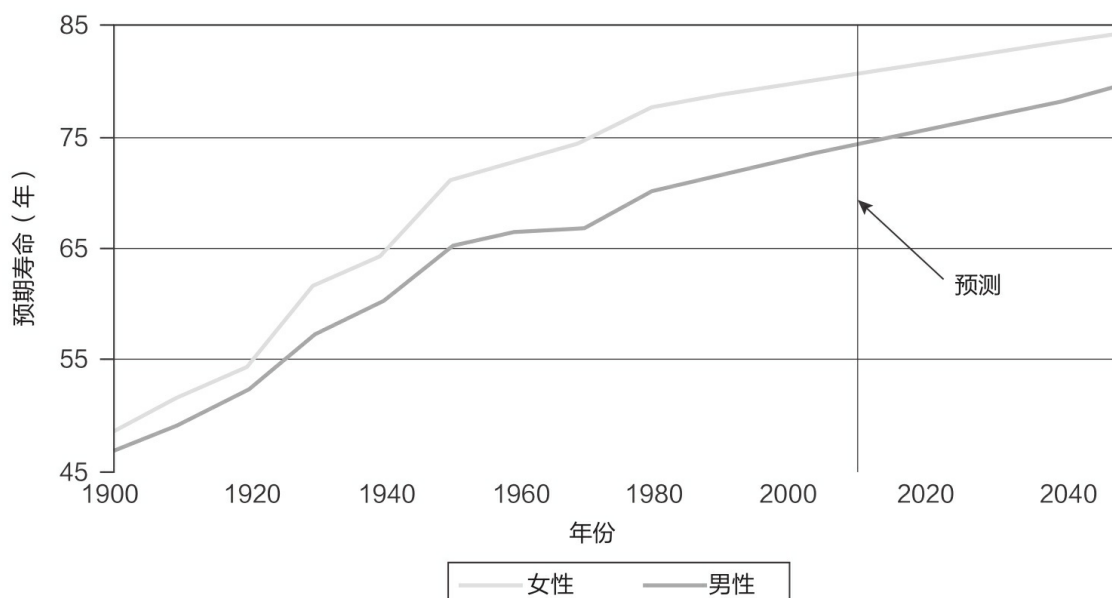


图9-6 持续增长的预期寿命

如果预期寿命的增加趋势一直延续下去，那么到21世纪末，活到100岁可能会是一件很普通的事。这对社会来说意味着什么？

资料来源：U.S.Bureau of the Census, 1997.

预期寿命的增加有多种原因。首先是人们的健康和卫生条件变得更好了，许多疾病如天花已被完全消灭，而且现在有很多疫苗和预防措施足以应对以前常导致年轻人死亡的疾病，如麻疹、腮腺炎等。其次，人们的工作条件普遍改善了，许多商品的安全性也得以提高。最后，越来越多的人开始选择健康的生活方式，如保持合理的体重、多吃新鲜蔬菜和水果、锻炼身体等。这些生活方式都可以延长人们的积极寿命。

人类的寿命到底能够增加到多少年呢？最常见的回答是，生命的上限在120岁左右，即1997年去世的122岁老人雅娜·卡尔曼特（Jeanne Calment）达到的水平，她是世界上迄今最长寿的老人。想要超出这个年龄，人类可能就要使自己的遗传特质发生重要改变，而这在技术上和伦理上都是不太可能的。但是，近期一些科学和技术上的进步表明，大幅度延长寿命并非不可能。

延缓衰老：科学家能找到永葆青春的奥秘吗 研究者就快要发现科

学意义上的青春源泉了吗？

目前还没有，但至少研究者在动物身上的发现已经非常接近答案了。例如，研究者已经将线虫，即一般只能活9天的微型透明蠕虫的生命延长到了50天，这相当于把人的生命延长到了420岁。研究者也成功将果蝇的寿命延长到了原来的两倍（Whitbourne, 2001; Libert et al., 2007; Ocorr et al., 2007）。

最有希望延长寿命的途径如下：

- 端粒治疗。端粒是位于染色体顶端微小的保护性区域，每经过一次细胞分裂，端粒就会变得更短，直至最终消失，并导致细胞停止复制。一些科学家认为，加长端粒能够延缓衰老，所以研究者正在试图找出哪些基因能控制生成端粒酶——一种似乎能调节端粒长度的酶（Urquidi, Tarin, & Goodison, 2000; Chung et al., 2007; Shalev et al., 2013）。
- 药物治疗。2009年，科学家发现一种叫雷帕霉素（rapamycin）的药物可以通过干预哺乳动物雷帕霉素靶蛋白（mTOR）的活性，延长老鼠14%的寿命（Blagosklonny et al., 2010; Stipp, 2012）。
- 解锁长寿基因。某些基因能够调控身体机能，以帮助个体应对环境中的挑战 and 身体出现的不利情况。如果加以利用，这些基因就可以为延长寿命提供支撑。一个特别有希望的基因家族是去乙酰化酶（sirtuins），它可以帮助延长寿命（Guarente, 2006; Sinclair & Guarente, 2006; Glatt et al., 2007）。
- 用抗氧化药物减少自由基。自由基是一种游离在身体内部的不稳定分子，它可以破坏其他细胞并引起衰老。第一，减少自由基数量的抗氧化药物的功效会越来越好。第二，或许还能在人体细胞内插入控制有抗氧化剂功能的酶生成的基因以减少自由

基。第三，营养学家还强调要多吃富含抗氧化维生素的食物，比如水果、蔬菜等（Kedziora- Kornatowski et al., 2007; Haleem et al., 2008; Kolling & Knopf, 2014）

- 限制热量。最近10年内的研究发现，在保证提供所需的全部维生素和矿物质的前提下，当提供的食物热量非常低时，即只相当于正常吸收量的30%~50%，实验室大鼠的平均寿命就比那些吃得好的大鼠要长30%，这似乎是因为饥饿的老鼠产生的自由基更少。研究者希望能够生产出一种药物，在不会让人感到饥饿的情况下来达到类似限制热量摄入所产生的效果（Mattson, 2003; Ingram, Young, & Mattison, 2007; Cuervo, 2008）。
- 仿生学方法：替换坏掉的器官。心脏移植、肝移植、肺移植等都可以被考虑，如今，替换受损或患病的器官已经是一件看起来很平常的事情了。

但一个较大的问题是，因为身体会排斥外来组织，所以移植手术常常会失败。为了解决排斥问题，一些研究者建议可以通过克隆自己的细胞来制作移植器官。一种更进一步的做法是，研究者可以对来自动物的、不会引起排斥反应的遗传改造细胞进行克隆、培养，然后植入需要移植器官的人身上。此外，技术上的进步也将会使通过培育人工器官来彻底替换患病或受损的器官成为可能（Cascalho, Ogle, & Platt, 2006; Kwant et al., 2007; Li & Zhu, 2007）。

延长人类寿命的科幻想法令人振奋，但有一个更需要解决的问题：不同种族和民族之间的平均寿命存在巨大差异。我们将在下面的“文化维度”专栏中进行讨论。

从医疗保健工作者的视角看问题

根据所学到的关于预期寿命的解释，你会如何尝试延长自己的寿命？

文化维度 预期寿命的性别、种族和族群差异

- 美国出生的白人平均能活到78岁，而非裔美国人平均要少活5.5年。
- 出生在日本的人预期寿命为83岁，而出生在莫桑比克的人预期寿命不到40岁。
- 出生在美国的男性平均能活到76岁，而女性可能会多活5年。

造成这些差异的原因有很多，我们先以差异最明显的性别差异为例来探讨。在工业化国家中，女性会平均比男性多活4~10年。女性的这种优势从母亲的孕期就开始了：虽然男孩的出生率略高些，但无论在母亲的腹中、婴幼儿期还是童年中期，男孩死亡的可能性都更大。所以，到了30岁，男性和女性的人数几乎相同。而到了65岁，84%的女性和70%的男性还活着。对85岁以上的老人而言，预期寿命的性别差异更大，男女比例为1:2.57（United Nations World Population Prospects, 2006; World Factbook, 2012）。

研究者对预期寿命的性别差异的解释有很多。一是女性天生会分泌更多的雌激素和黄体酮这两种激素，这在一定程度上帮助她们免受诸如心脏病等疾病的困扰。二是女性可能在生活中有更多的健康行为，例如饮食更合理。但是，没有确凿的证据能够充分支持以上任何一种解释（DiGiovanna, 1994; Emslie & Hunt, 2008; Aichele, Rabbitt & Ghisletta, 2016）。

无论是什么原因，预期寿命的性别差异都一直在增加。在20世纪早期，性别差异中的女性优势只有2年，但到20世纪80年代已增加到了7年。这个差异似乎正趋于平稳，主要是因为男性也比以往更注重保持积极健康的生活方式了，比如少抽烟、健康饮食、多运动。

种族和族裔差异更令人困扰，因为这体现了美国不同群体在社会经济状况上的明显差异。白种人的预期寿命要比非裔美国人的长10%（见图9-7）。此外，与预期寿命一直上升的白种人相比，非裔美国人的预期寿命近些年来还出现了轻微的下滑。

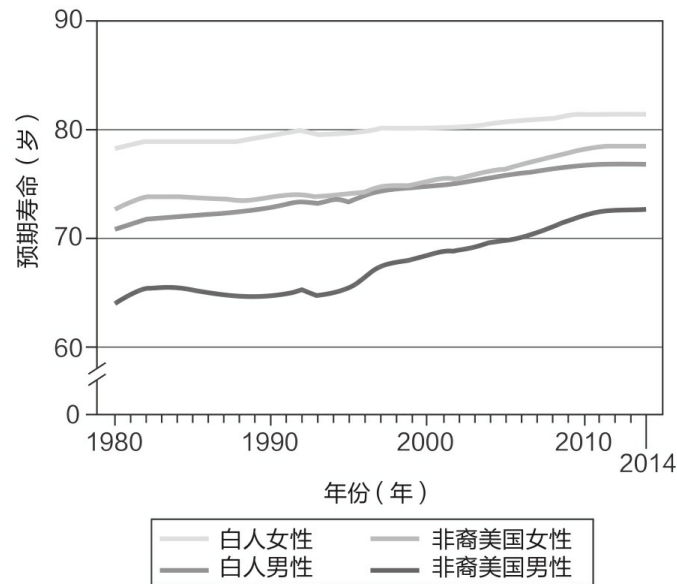


图9-7 非裔美国人和白人的预期寿命

非裔美国男性的预期寿命比白人男性的短，同样，非裔美国女性的预期寿命也比白人女性的短。

资料来源：National Center for Health Statistics, 2016.

回顾、检测和应用

回顾

学习目标9.1 描述有关衰老的误解与现实。

老年人常常受到歧视，受到基于年龄的指向老年人的偏见和歧视。不是所有的文化都会消极地看待衰老。在亚洲和美国土著社会中，年长者备受尊崇。

学习目标9.2 总结成年晚期发生的生理变化。

衰老会引起一些身体上的转变和内部变化。从外表来看，个体表现为头发灰白稀疏，身高也可能会由于椎间盘的软骨变薄而矮上数厘米。从内部来看，呼吸和消化系统的有效性会变差，大脑萎缩且需氧量变

少，但皮层细胞的数目只会有少量减少或者根本没有减少。从行为上来看，老年人的反应时会变长，不过尽管他们的身体能力可能已经改变了，但很多老年人还是保持着充沛的精力和活力。

学习目标9.3 解释衰老如何影响感觉。

衰老会给个体带来视觉、听觉、味觉和嗅觉的衰退。感觉的衰退会给老年人带来严重的心理后果。

学习目标9.4 总结老年人遭遇的健康问题，并列岀影响个体健康状况的因素。

许多老年人所患的疾病并不是老年人特有的，但是癌症和心脏病的发病率会随着年龄的增长而升高。成年晚期的个体也更可能患上关节炎、高血压、重度神经认知障碍和阿尔茨海默病。成年晚期个体的健康状况受多种因素的影响，包括遗传倾向性、环境因素及心理因素。在老年期，合理饮食、锻炼、回避危害健康的因素能够使老年人保持良好的健康状况。对健康的成人来说，性生活可以持续一生。

学习目标9.5 探讨有关衰老的不同理论，并总结有关延长预期寿命的研究。

死亡是遗传预设的结果还是由身体整体磨损所致，目前仍没有定论。几个世纪以来，人们的预期寿命一直在增加，它因性别和种族不同而有所差异。延长预期寿命的新方法包括端粒治疗、通过抗氧化类药物减少自由基、限制热量的摄入以及替换患病的器官等。

自我检测

1. ____衰老包括由于遗传程序的预先设定而出现的普遍且不可逆转的变化。

- a. 次级
 - b. 内部
 - c. 钝性
 - d. 初级
2. 60岁以上老人失明的最主要原因是_____。
- a. 老年性黄斑变性
 - b. 白内障
 - c. 两眼间晶状体退化
 - d. 青光眼
3. 阿尔茨海默病是一种____，每年在美国导致10万人死亡，并影响接近半数的85岁以上老人。
- a. 退行性细胞障碍
 - b. 慢性高血压
 - c. 渐进性大脑障碍
 - d. 神经认知免疫疾病
4. 衰老的____理论认为DNA包含了人体细胞繁殖的内置时间限制。
- a. 磨损
 - b. 预期寿命
 - c. 遗传预程
 - d. 化学接触

应用于毕生发展

社会经济地位与成年晚期的健康状况、预期寿命有何联系？

9.2 成年晚期的认知发展

不是我开车

格蕾丝和海伦都80岁了，她们一边像平时那样开车去市场，一边悠闲地抱怨着自己遇到的关于老龄的琐碎烦恼。海伦坐在副驾驶，看到格蕾丝闯了一个红灯，她知道自己的视力不如以前了，就什么都没说。但当同样的情形在之后两个十字路口再次发生后，海伦知道这不是自己视力的问题了，于是说：“格蕾丝，你没事吧？你刚闯了三个红灯，难道都没看到吗？”

“天哪！”格蕾丝惊呼，“我以为你在开呢。”

这个老掉牙的笑话在本节的开头就为我们展示了人们对老年人的刻板印象——糊涂、健忘。但如今人们对此的观点已大为不同，研究者推翻了老年人的认知能力必然会下降这一结论，转而认为老年人的整体智力与诸如记忆和问题解决的特殊认知能力更有可能保持良好。事实上，通过适当的训练和接触合适的环境刺激，老年人的认知能力能够切实得到改善。

本节将讨论个体在成年晚期的智力发展。我们不仅将考察老年人的智力本质和认知能力变化的多种方式，而且将评估成年晚期不同种类记忆的变化情况以及减缓老年人智力衰退的方法。



智力改变

当1985年美国有线电视新闻网（CNN）不再与丹尼尔·肖尔（Daniel Schorr）就报道工作续约时，他已经69岁了，所有人看到他退休都不会感到吃惊——除了肖尔本人。

他并没有搁置起自己的打印机，而是很快在美国全国公共广播电台（NPR）找到了工作。直到去世前两周，93岁的肖尔仍然定期向美国全国公共广播电台的《周末版》《万事皆晓》和其他新闻节目提交相关的分析和评论。

肖尔持久的智力活动并不常见，但他也不是个例。越来越多依靠自身智慧谋取生计或纯粹为了不断进取的人，在令人难以置信的年龄阶段仍然保持着智力上的活跃。仅仅在娱乐圈内，就有活跃到100多岁的喜剧演员鲍勃·霍普、乔治·伯恩斯以及作曲家欧文·柏林。

老年人的认知功能

学习目标9.6 描述在确定与年龄有关的智力变化的原因时遇到的难题。

关于老年人的认知能力会不断退化的观点最初来自人们对研究结果的误解。这些研究比较了年轻人和老年人在同一智商测验上的得分，使

用的是传统的横断研究。例如，研究者用相同的测验对一组30岁的被试和一组70岁的被试进行测试，然后比较他们的成绩。

但是，横断研究无法排除同辈效应的影响，如果年轻组的成员由于其成长的时代特征而平均接受了更多的教育，那他们仅凭这点就可能在测验中取得更好的成绩。此外，一些智力测验还会限定时间，那么老年人的成绩更差可能是由于他们的反应时更长。

纵向研究也不是一个特别好的研究方法。正如我们之前所讨论的，重复接受相同的测验可能会让被试对测验题目非常熟悉，从而降低测验结果的价值。而且，随着时间的推移，一些被试可能不再参与实验，而只留下了一个可能更小且更有认知能力的被试群体。

关于成年晚期智力本质的最新结论

学习目标9.7 总结衰老对认知功能的影响，并找出可能影响认知功能的因素。

近年来，越来越多的研究正在尝试克服横断研究和纵向研究各自的缺点。本书成书时，发展心理学家沙因正在主持一项目标远大且持续不断的关于老年人智力的研究，采用序列设计的方法，即将横断设计和纵向设计结合起来，在若干时间点考察不同年龄组的被试。

在这项庞大的研究中，沙因在西雅图随机选择了500名被试，对其进行了一系列认知能力测验。这些被试的年龄范围为20~70岁，以5岁为间隔进行分组。研究者每7年对这些被试进行一次测验，而每年都有更多的新被试参与进来。到目前为止，接受测试的总人数已超过5 000名（Schaie, Willis, & Pennak, 2005）。

这项研究和其他研究一道提出了如下结论（Craik & Salthouse, 1999, 2008）：

- 从25岁开始，个体的某些能力逐渐下降，而另一些能力则保持相对稳定（见图9-8）。成年期个体的各类智力能力随年龄增长的变化模式各不相同。例如，流体智力会随着年龄的增长而衰退，而晶体智力则保持稳定，在某些情况下甚至会上升（Schaie, 1993; Deary, 2014）。

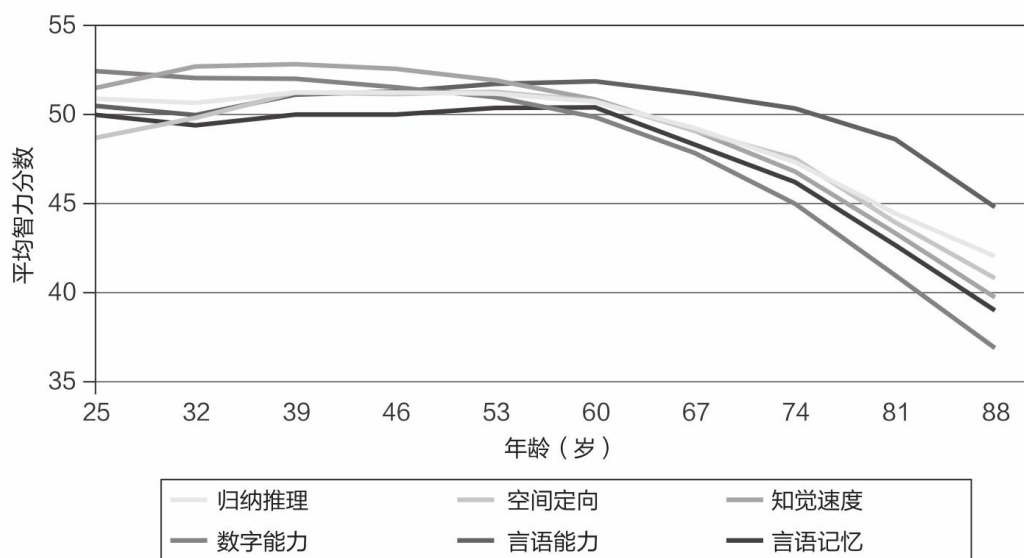


图9-8 智力功能的变化

尽管有些智力能力在成年期有所下降，但另外一些能力仍保持相对稳定。

资料来源: Changes in Intellectual Functioning from Schaie, K.W. (1994). "The course of adult intellectual development." p.307. *American Psychologist*, 49, 304-313. Copyright© 1994 by the American Psychological Association.经授权后使用。

- 平均来说，在67岁之前，个体的所有认知能力都会有一定的下降，但下降幅度很小，直到80岁以后才会出现明显下降。即使在81岁时，也只有不到一半的人在测验中的成绩相比7年前各方面均有所下降。
- 智力的变化存在明显的个体差异。有些人在30岁后智力就开始衰退，而有些人直到70岁后智力才开始衰退。事实上，在70多岁的老年人中，1/3以上的老年人测验得分高于青年人的平均

水平。

- 环境因素和文化因素对智力同样有影响。如果个体没有罹患慢性疾病、具有较高的社会经济地位、置身于能够激发智力的环境中、具有灵活的人格类型、拥有聪颖的配偶、保持良好的知觉加工速度、对自己中年或老年早期的成就感到满意，那么其智力下降的幅度就会比较小。

环境因素和智力能力之间的关系表明，通过不断接受刺激、练习和激励，老年人能够维持他们的心智能力。这种可塑性表明，个体成年晚期的智力改变并非必然。那么，就像在个体发展的其他领域一样，智力领域由“用进废退”来形容也同样再合适不过。这也启发我们，或许的确存在一些帮助老年人保持信息加工能力的方法。

但是，并不是所有的发展心理学家都接受“用进废退”这一假设。发展心理学家索尔特豪斯认为，个体成年晚期认知能力内在的真实下降速度并不受心理训练的影响。相反，他认为，那些持续且频繁地参与竞赛性拼字游戏等智力活动的人在进入成年晚期后，会拥有“认知储存”，这使他们能够弥补认知能力的内在衰退，从而继续表现出一种较高的心智水平。但是，大多数发展心理学家仍然支持心理训练能够提高认知能力这一假设（Basak et al., 2008; Hertzog et al., 2008; Salthouse, 2006, 2012a, 2012b）。



记忆丧失在西方老年人中很常见。哪些因素导致了老年人记忆丧失的文化差异？

记忆与学习

我能记起四五十年前发生的所有事情，包括日期、地点、表情、音乐等。但11月14日就是我90岁的生日了，我发现自己根本记不住昨天发生的事情（Time, 1980, p.57）。

这是作曲家阿隆·科普兰（Aaron Copland）对自己年老后记忆状况的描述，其中的一个错误让我们更加确信科普兰的分析是准确的：因为下个生日时，他只有80岁！

记忆

学习目标**9.8** 解释成年晚期的记忆能力会如何变化。

记忆丧失无可避免吗？不一定。跨文化研究表明，相比于不太尊敬老年人的国家，高度尊敬老年人的国家的老人更不容易出现记忆丧失。在这类文化中，人们对老年人更积极的预期可能会让老年人更加乐观地看待自己的能力（Levy & Langer, 1994; Hess, Auman, & Colcombe, 2003）。

确实发生的记忆力衰退也主要限于情景记忆（episodic memories），即与特定生活经验有关的记忆，比如回忆你第一次游览纽约的年份。其他类型的记忆，如语义记忆（semantic memories），即与一般知识和事实有关的记忆（如北达科他州的首府）和内隐记忆，即人们没有明显意识到的记忆（如怎样骑自行车），基本上不会受到年龄的影响（Nilsson et al., 1997; Dixon & Cohen, 2003; Nilsson, 2003）。

老年期的记忆能力确实发生了变化，例如，短时记忆能力在成年期会逐渐衰退，到70岁时衰退加速。遗忘最快的是那些以口述形式快速呈现的信息，比如电脑服务热线的接线员要快速背诵的、用于解决电脑问

题的一系列复杂步骤。另外，老年人会很难回忆起那些与不熟悉事物相关的信息，例如一些散文段落、人的名字和面孔，甚至包括像药品使用说明这类重要的信息，这很可能是因为老年人在遇到新信息时很难对它们进行有效的记录和加工。但是，这些变化都很小，大多数老年人会自动学会如何对其进行补偿（Light, 2000; Rentz et al., 2010; Carmichael et al., 2012）。

自传式记忆：回忆我们生活的每一天 谈到自传式记忆，即对自身生活信息的记忆，老年人和年轻人一样会遭遇衰退。例如，回忆常常遵循快乐原则（*pollyanna principle*），即愉快的记忆比不愉快的记忆更容易被想起来。类似地，在关于自己过去的信息中，人们更容易忘记那些与他们现在对自己的看法不一致的部分。他们更可能记起符合当下自我概念的信息，就像严格的父母不会记起自己曾经在高中舞会上喝醉过一样（Loftus, 2004; Rubin & Greenberg, 2003; Skowronski, Walker, & Betz, 2003; Martinelli et al., 2012）。

人们对生命某些阶段的记忆要优于对其他阶段的记忆。在进行自传体回忆时，70岁老人能回忆起自己二十几岁和三十几岁时更多的细节，而50岁的人对自己十几岁和二十几岁的记忆更多（见图9-9）。对这两个年龄段的人来说，他们对早年的回忆都要好于对近几十年的回忆，但是对其回忆的完整性不如近期事件（Fromholt & Larsen, 1991; Rubin, 2000）。

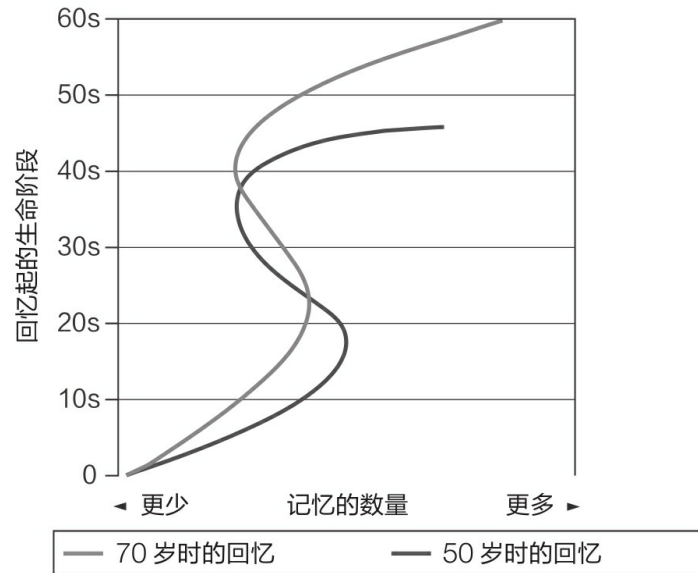


图9-9 对过去事件的回忆

自传式记忆会随着年龄的增长而发生变化，70岁的人关于自己二十几岁和三十几岁的回忆最丰富，50岁的人关于自己十几岁和二十几岁的回忆最丰富。处于这两个年龄段的个体都对近期事件回忆得最完整。

资料来源：Rubin, 1986.

成年晚期个体做决定时，他们所使用的回忆起信息的方式与年轻人不同。例如，当存在复杂规则时，一方面，老年人的信息加工速度很慢而且容易做出欠佳的判断，他们比年轻人更关注情感内容。另一方面，成年晚期个体积累的知识和经验可以抵消他们的不足，尤其是在他们很有动机做出正确决定的时候（Peters et al., 2007）。

解释成年晚期的记忆变化 对老年人记忆发生明显变化的解释主要集中在三大方面：环境因素、信息加工缺陷和生物因素。

- **环境因素。**对一些老年人来说，常见的特定环境因素会导致记忆衰退。例如，老年人经常服用一些妨碍记忆的处方药，因此老年人在记忆任务上成绩较差可能与服用相关药物有关，而不是与年龄有关。另外，退休后的老人不再面临工作上的挑战，也会较少地使用记忆功能。而且，他们回忆信息的动机可能也不如以前了，在实验的测验情境中，他们可能不会像年轻人那

样尽自己最大的努力了。

- 信息加工缺陷。记忆衰退也可能与信息加工能力的变化有关。老年人对干扰问题解决的无关信息及想法的抑制能力可能会减弱，所以信息加工速度也会减慢（Palfai, Halperin, & Hoyer, 2003; Salthouse, Atkinson, & Berish, 2003; Ising et al., 2014）。信息加工的另一种观点认为，老年人不能将精力集中在新信息上，且他们在面临相关刺激时集中注意力、组织记忆中的信息等方面也有很大困难。这种信息加工缺陷观点得到了大多数研究结果的支持。这种观点认为，老年人从记忆中提取信息的效率比较差。信息加工缺陷最终会导致老年人记忆力的衰退（Castel & Craik, 2003; Luo & Craik, 2008, 2009）。
- 生物因素。最后一种解释老年人记忆衰退的主要观点集中在生物因素上。这种观点认为，记忆的改变是由大脑和生理的衰退所致。例如，情景记忆的衰退可能与大脑额叶的退化或雌性激素的减少有关。一些研究也发现，老年人的海马细胞数量有所减少，而海马是与记忆有关的重要脑区。不过，有些老年人虽然没有表现出生物方面退化的任何迹象，但仍然出现了特定种类的记忆缺陷（Eberling et al., 2004; Lye et al., 2004; Bird & Burgess, 2008; Stevens et al., 2008; Sandrini et al., 2016）。

活到老学到老

学习目标9.9 找出老年人可以获取的学习机会，并描述这些机会对认知功能的作用。

蒂尔登和赫兹都71岁了，他们喜欢到大都会歌剧院观演，谈论男高音、芭蕾舞，以及他们在“林肯中心艺术节”期间刚刚参加完的演讲。

蒂尔登和赫兹是“马路学者”（Road Scholar）的资深成员，该组织

的前身是“老年旅舍”，组织的更名是为了彻底避免让人联想起“年老”或面向学生的便宜住宿。蒂尔登和赫兹参加过所有教育项目都能享受舒适的旅馆或宿舍，而且都是混龄活动。现在，蒂尔登和赫兹正在讨论他们下一次的活动，考虑是去安大略进行一次野生动物之旅，还是参加其他什么项目。



使用高科技设备的老年人越来越多。

“马路学者”是面向成年晚期个体的最大的教育计划之一，在全世界范围内提供旅行和学习课程。“马路学者”在全世界的各个大学校园内推行，这更进一步证明了智力的发展和改变是持续一生的。如我们之前所看到的，认知训练可以帮助老年人维持其智力功能（Simson, Wilson, &

Harlow-Rosentraub, 2006)。

另外，许多公立大学都提供免费的课程，以鼓励老年人参加。另外，一些退休老人聚居的社区也往往位于或邻近大学校园（Powell, 2004）。

虽然一些老年人对自己的智力能力有所怀疑，因此回避与年轻学生一起在常规大学的课堂上竞争，但他们的顾虑多半是错的。老年人在严格的大学课堂上保持自己的地位通常不会很困难。此外，教授和其他学生也普遍认为，这些有着丰富生活经历的老年人和自己一起上课，往往会给教学带来莫大的帮助（Simson et al., 2006）。

老年人和年轻人最大的代沟之一是高科技设备的使用。65岁及以上的老人使用科技产品的可能性远小于年轻人（如图9-10）。

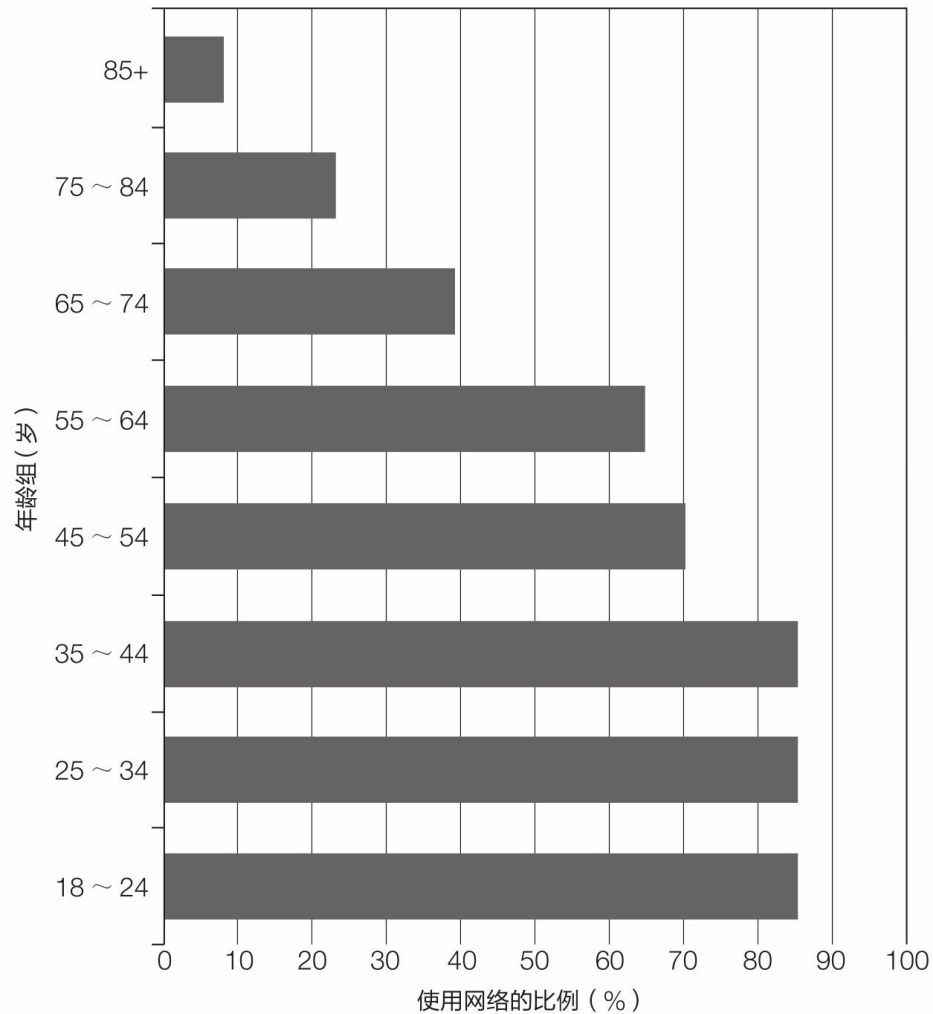


图9-10 科技产品的使用与个体年龄

美国老年人使用互联网的人数比年轻人少。

资料来源: Charness & Boot, 2009, Figure 1A.

为什么老年人不太使用科技产品呢？一个原因是他们既对科技产品不感兴趣，也因为工作内容的减少而不太需要学习新科技技能。另一个原因是认知方面的障碍。例如，因为随年龄增长而衰退的流体智力，可能会影响老年人学习技术的能力（Ownby et al., 2008; Charness & Boot, 2009）。

这并不是说成年晚期的人不会使用科技产品。事实上，越来越多的老年人开始使用电子邮件和社交网站。从整体社会来看，随着科技的

广泛应用，老年人与年轻人之间在使用技术上的差距可能会日趋缩小（Lee, Czaja, & Sharit, 2009）。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标9.6 描述在确定与年龄有关的智力变化的原因时遇到的难题。

由于同辈效应及其他难题，使用横断研究或纵向研究均难以对伴随年龄增长的智力改变的原因给出结论。

学习目标9.7 总结衰老对认知功能的影响，并找出可能影响认知功能的因素。

虽然一些智力能力在25岁以后会逐渐下降，但另一些智力能力会保持相对稳定。例如，研究发现流体智力会随着年龄的增长而衰退，而晶体智力则在成年晚期保持稳定，在某些情况下甚至会上升。伴随年龄增长的智力改变没有统一的模式。可能影响认知功能的因素包括环境因素和文化因素。

学习目标9.8 解释成年晚期的记忆能力会如何变化。

记忆衰退主要影响情景记忆和短时记忆。对老年人记忆变化的解释主要有环境因素、信息加工缺陷和生物因素三类。

学习目标9.9 找出老年人可以获取的学习机会，并描述这些机会对认知功能的作用。

类似“马路学者”这样的教育项目为老年人提供了学习机会。许多公立学院也鼓励老年人参加课程。运用认知技能可以帮助人们在成年晚期

保持智力功能良好。

自我检测

1. 横断设计研究衰老与认知时遇到的一个问题是这种方法没有考虑____，即成长的特定年代所造成的影响。
 - A. 遗传效应
 - b. 环境效应
 - c. 同辈效应
 - d. 宗教效应
2. 环境因素与认知能力之间的关系表明，____可以帮助老年人保持心智能力。
 - a. 刺激、练习和激励
 - b. 练习、和善的配偶和灵活的人格类型
 - c. 自传式记忆、激励和处方药
 - d. 更高的雌激素水平、练习和同辈群体
3. 在自传式记忆中，老年个体与年轻个体一样，遵循____，更容易回想起愉快的记忆。
 - a. 凸显原则
 - b. 语义效应
 - c. 快乐原则
 - d. 积极效应
4. 随着____，年轻人与老年人之间的科技技能代沟可能减小。

- a. 年轻成人获得工作，组成家庭，并忙于使用社交媒体
- b. 科技的使用在社会中继续增加
- c. 科技带来更简单的机器和针对老年人的特别程序
- d. 人们在网上对老年人给予更多尊重

应用于毕生发展

文化因素，如社会对老年人的尊敬程度，可能会怎样影响老年人的记忆能力？

9.3 成年晚期的社会性和人格发展

在阳光下漫步

81岁的西蒙娜在位于加利福尼亚州家中的花园里摆好了画架和水彩颜料。“我给童书画插图，已经画了50年了。”她说。西蒙娜曾经希望成为著名画家，并在读完艺术学校后前往直意大利追寻她的梦想。“我没能成为米开朗琪罗第二，”她大笑着说，“但我的生活过得还不错，还在那里遇见了我的丈夫加布里埃尔，事情还能比这更好吗？”

丈夫5年前去世了。“撑过第一年确实很难，”西蒙娜承认，“我去了意大利，回想起我们相遇、相恋的一切。我哭了好几次，但接着回到家，开始给两本新书画插图。工作就是我的生命线，虽然现在的工作量只有以前的一半，但收入够付房租。我可以花时间做自己喜欢的事情，比如尽管弹得很糟糕但仍让我乐此不疲的钢琴练习，以及带着来看我的孙辈们在海边漫步。”



西蒙娜最近的生活中有什么新鲜事呢？“去年我弟弟德夫的妻子因为癌症去世了，我就让他到我这来住。我们的关系一直很好，他能把烹饪和其他事情都做得特别好。我们会是一对快乐的老家伙，常在阳光下漫步。”

不管在任何年龄段，都有人有志于做出一番事业来。而像西蒙娜这样的老人，他们磨炼了一生的才能和与家人的紧密联系为他们提供了丰富的机会来继续积极生活和与他人保持联系。

本节中，我们将讨论成年晚期个体在社会性与情绪方面的特点，这些方面对老年期来说非常重要，正如它们在生命的前几个阶段中具有举足轻重的地位一样。首先，我们将思考人格在老年个体中是如何连续发展的，然后考察顺利老化的不同方式。我们还将考察文化会如何塑造我们对待老年人的方式。

其次，我们将探讨各种社会因素会如何影响老年人，如生活安排、经济和财务问题。我们还将探讨工作和退休对老年人的影响。

接着，我们将考察成年晚期的人际关系，包括个体夫妻之间，个体与亲戚、朋友之间的关系。我们将了解成年晚期的社会网络如何在人们生活中继续起重要且持久的作用。最后，我们将讨论老年人遭受虐待这一问题。

人格发展和顺利老化

格雷塔·罗奇去年因为弄伤了膝盖而不得不退出保龄球联赛，所以她没法在起居室桌子上那排蓝色抛光铬奖杯中再添一座了，不过她并不觉得膝伤说明人老了身体就会变差。

93岁的罗奇对待生活的积极态度和她二十几岁时一样，这并不是所有老年人都能做到的……“我享受生活，参加各种俱乐部，喜欢在电话里聊天，喜欢给我的老朋友写信。”她停顿了一下，“给那些仍然还活着的老朋友。”（Pappano, 1994, pp. 19, 30）

罗奇在很多方面还和年轻时一样，她仍旧聪明、热情又活跃。而对其他老年人来说，时间和环境可能会让他们改变对生活的态度、对自己的看法甚至一些基本的人格特质。事实上，研究毕生发展的学者们需要回答的一个基本问题就是，成年晚期的人格在多大程度上是保持稳定或会有所变化的。

成年晚期人格的稳定性和变化

学习目标9.10 列出并描述有关成年晚期人格发展的各种理论。

人格在整个成年期会相对稳定还是会表现出显著变化呢？答案取决于我们探讨的是人格的哪些方面。发展心理学家科斯塔和麦克雷认为，“大五”人格特质（神经质、外向性、开放性、宜人性、尽责性）在成年期是十分稳定的。例如，在20岁时性情平和的人在75岁时也是性情平和的，在成年早期持有正性自我概念的人在成年晚期仍然能够积极地看待自己（Costa & McCrae, 1997; McCrae & Costa, 2003; Terracciano, McCrae, & Costa, 2010; Curtis, Windsor, & Soubelet, 2015）。

以罗奇为例，她在93岁时仍然像二十几岁时一样活跃且幽默。由此看来，人格具有基本的稳定性（Field & Millsap, 1991）。

尽管基本人格特质具有一般稳定性，但仍可能发生改变。社会环境的重大改变可能会造成个体人格的波动和改变。对一个80岁的人来说很

重要的东西，和他在40岁时认为重要的东西未必是相同的。

为了解释这些变化，一些研究者把关注点放在了发展的不连续性上。正如我们将要看到的，埃里克森、罗伯特·佩克（Robert Peck）、莱文森和伯尼斯·钮加藤（Bernice Neugarten）的研究工作考察了成年晚期个体因为面临新挑战而造成的人格改变。

自我完善对失望：埃里克森理论中的最后一个发展阶段 按精神分析学家埃里克森的观点，在成年晚期，个体进入了生命中八个心理社会发展阶段的最后一个。这个时期被称为自我完善对失望阶段（**ego-integrity-versus-despair stage**），其特点是个体会对人生进行回顾、评价进而接受。

成功经历这个发展阶段的人会体验到满足感和成就感，用埃里克森的话来说就是“整合”。当人们达到整合这一状态时，就会觉得自己已经实现一生中的所有可能性了，因而也就没有遗憾。另一些人在回顾过去时却并不满意。他们可能觉得自己错过了一些重要机会，也没有实现自己的愿望。这些人可能会对自己做过的和没能做到的事情感到抑郁、愤怒或沮丧，总之他们很失望。

佩克的发展任务 尽管埃里克森的理论已经为成年晚期的发展描绘了一幅多样性的图景，但也有一些心理学家对生命的最后阶段提出了其他观点。发展心理学家佩克（1968）认为，老年人的人格发展由三个主要发展任务或挑战组成。

佩克对个体成年阶段的改变进行了全面描述，其中一条观点认为老年人的第一个任务是必须用与职位或职业无关的方式来重新定义自己，即自我重新定义对沉迷工作角色（**redefinition of self versus preoccupation with work role**）。正如我们接下来将会看到的，退休带来的变化将会引发老年人的适应困难，从而影响人们看待自己的方式。佩克建议人们最好调整自己的价值观，不要强调自己的职场角色，而应更关注自己与工作无关的角色，例如作为祖父或一名园丁。

佩克认为成年晚期的第二个发展任务是身体超越对身体专注（**body transcendence versus body preoccupation**）。随着身体的衰老，个体将会体验到明显的体能改变。在身体超越对身体专注阶段，人们必须学会应对和跳脱出那些由衰老所致的生理变化。如果做不到这一点，老年人就会把关注点全都落在自己的体能衰退上，从而损害其人格发展。90多岁时才停止打保龄球的罗奇，就是一个能成功应对老化所致生理变化的例子。

最后，老年人面对的第三个发展任务是自我超越对自我关注（**ego transcendence versus ego preoccupation**），此时个体必须认真面对即将到来的死亡。老年人需要知道，虽然死亡不可避免而且可能已经为期不远了，但他们已为社会做出了贡献。如果成年晚期个体认为诸如养育孩子或是工作和公益活动这些贡献将超越自己的生命而延续下去，那他们就能体验到自我超越感。否则，他们就会始终被自己的生命是否对社会有意义和有价值这个问题的困扰。

莱文森的最后季节：生命的冬天 莱文森的成年发展理论没有埃里森和佩克的理论那么注重老年人必须面对的挑战。相反，他关注个体年老时发生的导致人格改变的过程。莱文森认为，人们会通过一个过渡阶段进入成年晚期，这个阶段通常发生在60~65岁（Levinson, 1986, 1992）。在这一阶段中，人们终于认识到自己进入了成年晚期，或者说最终认识到自己是“老”了。因为他们很清楚社会对老年人的消极刻板印象是什么，所以很难接受自己已经被归入了这一范畴。

WHEN BABY BOOMERS HIT THEIR NINETIES

白内障会变得很“酷”。



社会上将会出现一种全新的佳肴，但再也看不到墨西哥菜和泰国菜了。



将会有设计得很好的手杖和助行车。



最畅销的书写的是100岁的生活是什么样子的。



当婴儿潮一代到达**90**岁时。

资料来源: Roz Chast.

莱文森认为，一方面，这一阶段的人们开始意识到自己不再处于舞台的中央，而要开始扮演次要角色。权力、尊崇和权威的丧失对那些习

惯了掌控自己生活的个体来说，是很难适应的。

另一方面，处于成年晚期的个体对年轻人来说也是一种资源，他们可能会发现自己被视为“受尊敬的长者”，因为年轻人会寻求甚至依赖他们的建议。而且，老年人拥有可以单纯为了愉悦感而做某事的自由，而不是迫于一些义务而去做某件事。

应对衰老：钮加藤的研究 钮加藤（1972, 1977）的经典研究考察了人们应对衰老的不同方式，他在对70多岁老人的研究中发现了4种人格类型：

- 整合不良型人格（disintegrated and disorganized personalities）：一些人不能接受衰老的事实。他们会对自己的逐渐衰老感到绝望。这些人通常是生活在护理院或正住院接受治疗的老人。
- 被动-依赖型人格（passive-dependent personalities）：有些人惧怕衰老、生病，惧怕未来和自己无法应付困难。他们太过恐惧，以致在自己可能并不需要帮助的时候，也要寻求家属和护理者的帮助。



老年人可能会变成“受尊敬的长者”，年轻人会寻求甚至依赖他们的建议。

- 防御型人格（defended personalities）：有些人会用一种特别的方式表达对衰老的恐惧，即试图阻止衰老的步伐。他们试图表

现得很年轻，比如进行需要旺盛精力的运动和参与年轻人的活动等。然而，他们可能因为设立了对自己来说不切实际的目标而不得不承担失望的风险。

- 整合良好型人格（**integrated personalities**）：最成功的个体能够平和地应对衰老。他们可以带着自尊接受变老的现实。

钮加藤发现，参与她实验的被试中，大多数人属于最后一类。他们承认衰老，能够坦然回顾自己的生活，并以一种接纳的态度展望未来。

生活回顾和怀旧：人格发展的共同主题 生活回顾（**life review**），即考查和评价自己过去的的生活，这一主题贯穿了埃里克森、佩克、钮加藤、莱文森对老年人人格发展的研究工作，也是关注成年晚期的多数人格研究者所讨论的共同主题。

老年学家罗伯特·巴特勒（**Robert Butler**）在2002年提出的观点指出，人们越来越清晰地认识到即将来临的死亡时，就会激发自己对生活的回顾。人们会回顾自己过去的的生活，回忆和反思自己经历过的事情。生活回顾并不是重蹈覆辙、沉湎于过去的问题以及重新剥开伤口的有害过程，相反，它可以帮助人们更好地理解过去。在这一时期，人们也许能够解决遗留的问题，例如与孩子的疏远问题；他们可能还会用更加平和的方式面对当前的生活（**Bohlmeijer, Westerhof, & de Jong, 2008; Korte, Westerhof, & Bohlmeijer, 2012; Latorre et al., 2015**）。

生活回顾还能带来其他好处，比如和他人联系时体会到的亲密感。另外，这可能会成为老年人的社交资源，因为他们可以与他人分享自己过去的经历（**Sherman, 1991; Parks, Sanna, & Posey, 2003**）。

生活回顾甚至还有益于认知能力，比如提高记忆力。回顾过去能够激活人们对过去人和事的记忆。这些记忆可能会激发其他相关的记忆，还可能使人们回想起过去的一些景象、声音甚至气味（**Brinker, 2013**）。

但是，生活回顾有时也会损害心理功能。容易沉湎于过去问题的人，往往会想起那些无法更改的陈年伤痛和错误，甚至最终可能会对已经过世的人感到内疚、抑郁和愤怒（Cappeliez, Guindon, & Robitaille, 2008）。

不过总的来说，生活回顾和怀旧的过程在老年人的生活中起着非常重要的作用。它提供了过去和现在之间的联结，还有可能提高人们对当前世界的认识。另外，它还能老年人提供看待过去事件和他人的新认识，使他们的人格继续稳定发展，并在当下更有效地发挥作用（Coleman, 2005; Haber, 2006; Alwin, 2015）。

成年晚期的年龄阶层理论

学习目标**9.11** 解释年龄与资源、力量及特权的分配之间的关系。

年龄，就像种族和性别一样，提供了一种区分社会中不同个体等级的方式。年龄阶层理论（**age stratification theories**）指出，经济资源、力量和特权在处于生命过程不同阶段的人之间的分配并不均衡。这样的不均衡在成年晚期尤为严重。

虽然医疗技术的进步能使人类寿命得以延长，但它阻止不了老年人力量和威望的逐渐衰退，至少在工业化社会中是这样的。人们普遍收入最高的年龄大约是50多岁，随后就开始减少。而且，年轻人通常不会与老年人住在一起，他们的日益独立会让老年人觉得自己不太重要。另外，科技的迅速发展也让老年人显得很落伍，他们似乎不太能够掌握重要的技能。最终，老年人就不再被看作是社会生产的主力军，在某些情况下甚至变得无关紧要（Cohn, 1982; Macionis, 2001）。莱文森认为，老年人能敏锐地意识到自己地位的降低，而适应这一点则是成年晚期的主要转变。

年龄阶层理论有助于解释为什么在工业化没那么发达的社会中，人

们对老龄的看法较为积极。在农业活动占主导的文化中，老年人拥有对动物和土地等重要资源的控制权，这种社会也不存在退休的概念。老年个体尤其是老年男性会非常受尊敬，因为他们还在继续参与重要的社会日常活动。而且，因为农业社会的变迁速度比工业社会慢，所以在农业社会中，人们会认为老年人拥有更多的智慧。对老年人的尊敬并非仅限于农业社会，它是多种文化的共同特征（见“文化维度”专栏）。

文化维度

文化差异怎样影响我们对待老年人的方式

人们看待成年晚期的方式是有文化差异的。例如，普遍来说，亚洲社会中的人们比西方社会中的人们更加尊重老年人，尤其是自己家里的老人。虽然在工业迅速发展的亚洲地区，这种情况在改变，但亚洲人对老龄的看法和对待老年人的方式，仍然比西方社会更积极（Cobbe, 2003; Degnen, 2007; Smith & Hung, 2012）。

是什么让亚洲文化中的人对老年人更加尊敬呢？一般而言，那些崇尚尊敬老年人文化的社会，在社会经济方面是相对同质的。另外，在那样的社会中，人们会随着年龄增长担负更多的责任，老年人也对资源有更大的控制权。

此外，亚洲社会中的人们在一生中的角色比西方社会更稳定，老年人通常会继续参与社会所看重的活动。最后，亚洲文化更注重大家庭的组织，而老一辈的人很好地融入了这种结构中（Fry, 1985; Sangree, 1989）。在这样的环境中，年轻的家庭成员更要仰赖老年人日积月累的智慧了。

但是，即使在那些高度强调尊老的社会中，人们也并不会始终遵照这类准则行事。例如，有些国家的人们对老年人有着强烈的钦佩、尊敬甚至崇拜之情，但除了在面对精英阶层的老人时，人们的实际行为并不像他们所说的那么好。另外，有些社会中通常是由儿子和儿媳妇照顾老人，那些只有女儿的父母却没人照顾。简单来说，即使在特定文化中，人们对待老年人的行为也不一致，所以最重要的是不要轻易对某个社会中的人下广泛、普遍的结论（Comunian & Gielen, 2000; Browne, 2010; Li, Ji, & Chen, 2014）。

亚洲文化并不是唯一一种尊重老年人的文化。在很多拉丁文化中，老年人被认为有一种特殊的内在力量；在非洲文化中，变老似乎是神介入的标志（Holmes & Holmes, 1995; Lehr, Seiler, & Thomae, 2000）。



是什么原因让亚洲文化对老年人更加尊重呢？

年龄增长能带来智慧吗

学习目标**9.12** 对智慧下定义，并描述它与年龄有何关系。

人们认为年龄增长的好处之一是会更有智慧。但随着年纪变大，人们真的能获得智慧吗？

事实上并无定论，因为智慧（**wisdom**）的概念，即在生活实践方面的专业知识直到最近才得到老年学家和其他研究者的关注。部分原因是“智慧”难以进行定义和测量（Helmuth, 2003; Brugman, 2006）。智慧可被视为对知识、经验和思想积累的反映。从这种定义来看，年龄增长的确可以提升智慧（Kunzmann & Baltes, 2005; Staudinger, 2008; Randall, 2012）。

智慧和智力有微妙的区别。一些研究者认为，由智力产生的知识与当前有关，而智慧相对来说则是永恒的。智力能让个体有逻辑地、系统地思考，而智慧是个体对人类行为的理解。根据心理学家斯滕伯格的观点来看就是，智力让人类发明原子弹，而智慧能阻止人们使用它（Karelitz, Jarvin, & Sternberg, 2010; Wink & Staudinger, 2016）。

智慧很难测量。不过巴尔特斯和厄休拉·斯托丁格（Ursula

Staudinger) 在2000年设计的一个研究表明, 稳定地测量人们的智慧是有可能的。在这项研究中, 被试年龄为20~70岁, 他们被安排两人一组讨论与生活事件有关的难题。其中一个情境是有人接到一个好友的电话, 对方说自己打算自杀; 另一个情境是一名14岁的女孩想立即搬离自己的家。接着研究者询问被试, 他们此时应该做什么以及考虑什么。

虽然这些问题没有绝对正确或错误的答案, 但有几个标准可以用来评价被试的回答, 其中包括: 被试运用了多少关于那个问题的事实知识, 被试具备多少关于决策的知识, 被试在多大程度上考虑到主人公所处的生命周期和可能拥有的价值观所构成的背景, 被试是否能意识到可能不止一个解决办法。根据这些标准来评估, 研究者发现老年被试的回答比青年被试更成熟。

该研究还发现, 老年被试会从旨在促进个体睿智地思考的实验条件下获益更多, 其他研究者也认为最有智慧的个体是那些老年人。

也有研究者根据心理理论的发展来考察智慧。心理理论 (**theory of mind**) 是一种推测他人想法、感受和意图等心理状态的能力。虽然研究结果不一致, 但一些研究表明, 老年个体运用他们随着年龄而积累的经验, 可以更成熟地运用心理理论 (Karelitz, Jarvin, & Sternberg, 2010; Rakoczy, Harder-Kasten, & Sturm, 2012; Booker & Dunsmore, 2016)。

顺利老化: 秘诀在哪儿

学习目标9.13 找出各种衰老理论之间的区别, 并解释文化如何影响人们对待老年人的方式。

77岁的埃莉诺的大部分时间都在家里度过, 她的生活平静又规律。埃莉诺一生未婚, 她的两个妹妹每隔几个星期就会来探望她一次, 外甥和外甥女们也偶尔来一下。但绝大多数时间, 她都是一个人度过的。不过每当有人问起, 她都会说这样的生活很快乐。

相反，凯莉也是77岁，她却几乎每天都做着不同的事情。如果不去老年中心参加某些活动，她就会去购物。凯莉的女儿抱怨说，每次打电话找她时，她都不在家，而凯莉则说，她从未因如此繁忙而开心过。

显然，顺利老化没有单一的方式。人们如何老化取决于自身的人格因素和所处的环境。一些人参与的活动日渐减少，另一些人则继续与他人保持着积极的联系并坚持自己的爱好。有三个主要理论对此进行了解释：脱离理论、活跃理论和连续理论。

脱离理论：逐渐隐退 脱离理论（**disengagement theory**）指出，成年晚期个体通常在生理、心理和社会性维度上从外界活动中逐渐隐退（Cummings & Henry, 1961）。在生理方面，老年人的精力水平会不断降低，生活节奏也逐渐减慢；在心理方面，他们开始从人群中退出，减少了对外界的兴趣，更多的时间是在关注自己的内心世界；在社会性方面，他们减少了日常面对面交流和总体的社会活动。老年人对他人生活的参与和投入也变得少了（Cashdollar et al., 2013）。

脱离理论认为，隐退是一个相互的过程。由于社会标准和人们对老化的预期，总体上社会也在远离老年人。例如，强制性的退休年龄迫使年纪大的人离开岗位，从而加速了老年人的脱离。

尽管脱离理论有一定的逻辑，但能支持它的研究成果十分有限。而且，这一理论还受到了一些批评，批评者认为社会并没有给老年人提供有意义的参与机会，反而还怪罪处于这一年龄阶段的人参与度不够。

当然，一定程度的隐退并非完全是消极的。例如，老年人的逐渐隐退能使他们有更多时间来思考自己的生活，社会角色对他们的束缚也更少了。而且，老年人其实能够更好地区分自己的社会关系，从而把精力放在那些能满足他们需要的人身上（Settersten, 2002; Wrosch, Bauer, & Scheier, 2005; Liang & Luo, 2012）。

也有一些老年学家驳斥了脱离理论，他们认为脱离是相对少见的。

大部分情况下，人们在老年时期仍会保持参与、活跃和忙碌的状态，尤其是在很多非西方文化的社会中，社会预期也认为他们将在日常生活中保持这种活跃状态。显然，老年人的脱离并不是自动化、普遍的过程（Bergstrom & Holmes, 2000; Crosnoe & Elder, 2002）。

活跃理论：继续参与 由于支持脱离理论的证据不多，人们又给出了另一种解释。活跃理论（**activity theory**）认为，顺利老化需要将成年中期的兴趣、所从事的活动以及社会交往的总量和类型继续保持下去。这一观点指出，人们可以通过适度参与外界活动来获得生活的幸福感和满意感（Hutchinson & Wexler, 2007; Rebok et al., 2014）。

活跃理论认为老年人继续从事活动是十分重要的。即使在不能继续某活动的情况下，比如退休后不再继续工作时，活跃理论也主张人们寻找替代活动，以达到顺利老化。

但活跃理论也像脱离理论一样，不能对所有情况进行解释。首先，活跃理论几乎没有区分各种类型的活动，而各种活动对人们的幸福感和满意度的影响显然是不一样的。事实上，老年人参与活动的性质和质量，比单纯的参与频率或总量对他们来说更为重要（Adams, 2004）。

需要注意的是，“以少得多”的原则或许更适合某些老年人：更少的活动能带来更多的生活乐趣，因为他们可以放慢生活节奏，仅仅做那些给自己带来最大快乐的事情。事实上，一些人将能够自主地调整生活节奏视为成年晚期最大的好处之一。对他们来说，活动相对较少甚至是独处的状态，可能才是他们想要的生活状态（Hansson & Carpenter, 1994）。

从社会工作者的视角看问题

文化因素如何影响老年人采用脱离策略或活跃策略的可能性？

连续理论：折中的立场 脱离理论和活跃理论都没有描绘顺利老化的全景（Ouweland, de Ridder, & Bensing, 2007），这就需要一个折中的理论。连续理论（**continuity theory**）认为，人们仅保持自己所希望的社会参与水平，就能体验到最大程度的幸福感和自尊感（Whitbourne, 2001; Atchley, 2003; Pushkar et al., 2010）。

连续理论指出，那些高度活跃和社交性很强的人，如果在老年能尽量保持这种状态，就会感到很快快乐。而如果是喜欢独处、单独活动的人，例如喜欢独自看书或在丛林中散步的人，如果在老年也保持这种水平的社会性，他们就会非常快乐（Holahan & Chapman, 2002; Wang et al., 2014）。

另外，大多数老年人可以体验到和年轻个体一样多的正性情绪，而且他们在调节自己的情绪方面也会变得越来越熟练。

还有一些其他因素可以提高个体成年晚期的幸福感。生理和心理健对老年人的总体幸福感很重要，拥有足够的经济保障以满足其基本需求也至关重要。同时，自主感、独立性和对个人生活的控制感也对老年人的幸福感非常有帮助（Charles, Mather, & Carstensen, 2003; Charles & Carstensen, 2010; Vacha-Hasse, Hil, & Bermingham, 2012）。

正如我们之前所讨论的，人们的知觉会影响其幸福感和满意度。乐观看待成年晚期的人相对于悲观看待成年晚期的人，会更善于用积极的眼光来看待自己（Levy, Slade, & Kasl, 2002; Levy, 2003）。

最后，有调查发现，成年晚期个体的整体幸福感要高于年轻人（见“从研究到实践”专栏）。而且，其原因并不是那些65岁以上的人之前一直都很幸福，而是大部分人变老时似乎会产生一定的满足感（Yang, 2008）。

通过补偿达到选择性最优化：顺利老化的普遍模型 在考虑顺利老化的因素时，发展心理学家巴尔特斯夫妇更推崇选择性最优化补偿策

略。如我们之前所讨论的，该模型的基础假设是成年晚期将带来个体潜在能力上的改变和丧失，但这因人而异。而且，人们有可能通过选择性最优化来克服能力改变所带来的影响。

选择性最优化策略指出，人们会通过选择性最优化来增加自己在动机、认知和体能上的整体资源。比如一个终身从事马拉松运动的人，为了加强训练，可能需要削减或完全放弃其他运动。放弃其他运动之后，他也许就可以进行集中训练以保持其跑步技能了（Burnett-Wolle & Godbey, 2007; Scheibner & Leathem, 2012; Hahn & Lachman, 2015）。

与之类似，老年人也会利用补偿行为来弥补由于衰老而丧失的能力。例如，人们可以戴上助听器以弥补听力的衰退。钢琴巨匠亚瑟·鲁宾斯坦（Arthur RubinStein）则是另一个通过补偿达到选择性最优化的例子。在鲁宾斯坦的晚年，他采取了一些策略以保持其表演效果：他减少了在音乐会上表演的乐曲数目，这是一个选择的例子；他更频繁地练习那些表演曲目，这是一个最优化策略的例子；最后，他减慢了快节奏乐曲之前那部分的演奏速度，相比之下，就好像他在快节奏演奏部分的速度还和以前一样，这是一个补偿行为的例子（Baltes & Baltes, 1990）。

简而言之，选择性最优化补偿策略道出了顺利老化的基本原则。虽然成年晚期可能会给个体带来各种潜在的能力改变，但那些尽力在特定领域取得成绩的人，能更好地补偿其他方面能力的局限和衰退。这样一来，老年人虽然在某些方面的活动会有所减少，但也有相应的转变和调节，最终其生活仍然是向好的。

从研究到实践 年龄仅仅是一种心理状态吗

如果你在1981年走进新罕布什尔州的一座修道院，你就会觉得自己仿佛在一瞬间进行了

一次时间旅行。在那个空间里，一切都回到了1959年。装饰、图书和杂志，甚至收音机和小黑白电视机里的节目都来自那个时候。不过，这不是“时间胶囊”，而是一项针对心理与身体之间关系的开创性研究。心理学家埃伦·兰格（Ellen Langer）⁽²⁹⁾邀请了6位70多岁的男性来到这座修道院，让他们在5天时间里过着突然“年轻”了20岁的生活。在这段时间里，他们看不见自己的倒影，只能看见自己50多岁时的照片。人们再不像对待老人一样对待他们，而是期望他们自理生活的种种。他们谈论20世纪50年代后期的事件，如同当前就是那个时候一样。研究以所有可能的方式创建了一种幻觉，令人感到过去的22年已被从自己的生命中擦去了（Grierson, 2014）。⁽³⁰⁾

研究产生了令人惊奇的效果：这几位被试并不仅仅是在假装变年轻，他们的行为真的变年轻了。被试在力量、灵活性等多项生理指标上的表现也提升了，视力也得到了改善！

兰格研究发现，个体衰老的减缓至少在某种程度上是一种心理状态。人们的行为显得苍老，是因为他们觉得自己老。但当他们觉得自己年轻，而且对生活有目的性和自主权的时候，他们就会变年轻。例如，兰格最近的研究继续表明，如果告诉被试他们的视力会改善，那么其视力水平就真的会改善（Alexander & Langer, 1990; Hsu, Chung, & Langer, 2010）。

兰格将心理与身体之间的联系称为正念（mindfulness）。正念的效果类似安慰剂效应：人们通常能够体会到他们期望体会的效果。兰格的相关研究为正念的真实性提供了大量证据：过早秃顶从而觉得自己老的男性患前列腺癌和冠心病的风险较高。如果女性做了她们觉得让自己显年轻的新发型，其血压就会降低。较晚生育的女性，其举止和感受会比实际年龄对应的状态年轻，通常寿命也更长。年龄相差较大的夫妻中，较年轻一方的预期寿命往往会低于通常值，而年龄较大一方的预期寿命往往高于通常值（Hsu, Chung, & Langer, 2010）。

兰格目前的研究将正念概念提升到了一个新高度，乳腺癌终末期的女性如果以20年前的状态生活，是否会如同新罕布什尔州修道院中的老年男性一般表现出积极的效果呢？兰格希望能通过让患者完全以癌症出现以前的状态生活，来让身体找到一种消除癌症的方法。这至少是一项大胆的实验，它以之前从未有过的高标准检验着兰格的正念概念，不过即使效果甚微，这也是革命性的。正念是否能通过检验，只有时间能证明（Grierson, 2014）。

对于兰格提出的各种年龄意识与健康的相关性，还可能有哪些其他解释？

成年晚期的日常生活

我10年前退休的时候，大家都告诉我说，我会想念工作，会变得孤独，会因为沒有工作的挑战而感到无聊。这太扯了！这10年是我生命中最快乐的时期。想念工作？一点儿也不！想念什么？会议？培训？晋升？当然，钱少了，同事少了，但是我有存款、爱好和旅行就足够了。

上述对成年晚期的积极看法来自一位75岁的退休保险员。尽管不是所有退休人员都有这样的想法，但还是有很多人会觉得退休后的生活是开心且有吸引力的。接下来我们将讨论人们在成年晚期的一些生活方式，就先从他们的住所说起吧。

居住安排：居住的地点和空间

学习目标9.14 描述为老年人安排住所的可能方式，并解释每种方式会如何影响他们的生活质量。

一想到“老年人”，你可能就会一下子想到护理院。但是事实并非如此。只有5%的人会在护理院里终老，大多数人都始终住在家里，而且至少有一名家庭成员陪伴。



在多代家庭中，与儿女、媳婿及孙子孙女一起生活，对成年晚期个体来说是有益的。那么这种情况是否也有不利的一面呢？有什么解决办法吗？

住在家里 很多老年人都是独自居住。美国960万独居的个体当中，有1/4是65岁以上的老人。在65岁以上的人群中，约有2/3的人与家人住在一起，多数情况是和配偶同住。一些老年人和兄弟姐妹同住，另一些则与子女、孙子孙女甚至曾孙子曾孙女等多代人一起居住。

不同的居住环境给老年人带来的影响也很不一样。对已婚老年夫妇来说，与配偶同住代表了对先前生活的延续。另外，搬去和子女同住的老人，会在适应多代人一起生活时面临困难。这不仅让老年人面临失去自主性和隐私的风险，还让他们因为看不惯自己孩子养育下一代的方式而与之产生冲突。除非人们对家庭成员所扮演的角色有既定的准则，否则双方很容易发生矛盾（Navarro, 2006）。

个体居住在大家庭中的现象在一些群体中尤为普遍。例如，黑人比白人更有可能居住在多代的大家庭中。而且非裔美国人、亚裔美国人、拉丁裔大家庭的家庭成员之间的相互影响和相互依赖程度要比白种人高很多（Becker, Beyene, & Newsom, 2003）。

专门的居住环境 大约有10%的老年人住在相应的照料机构中。事实上，老年人居住的机构有很多类型。

近来有关老年人居住安排的变革之一是连续照料社区（**continuing-care community**）的出现，这一社区环境的目标人群以到退休年龄及以上的人为主。社区会提供不同级别的照料，成员需要与社区签署一份关于他们所需照料级别的协议。在这样的社区中，人们刚开始是住在独立的房子或公寓中的，他们能够自理，或偶尔需要照顾。随着年龄的增长，他们会将级别转为协助生活（**assisted living**）。在这种级别中，人们仍单独住在房间里，但配有自己所需的相应医疗护理服务。连续照料最终会发展到全天护理，这一级别的护理服务通常在有全天陪护的护理院中进行。

连续照料社区的成员通常在宗教、种族和族裔方面有共同特征，社区通常由私人或宗教组织来主持。由于参加此类社区需要昂贵的首付，所以社区成员的经济水平都相对较好。但是，越来越多的连续照料社区的多样性也在不断增加，而且社区正通过建立日托中心和发展有更年轻人群参与的项目，来增加代际间的互动（Chaker, 2003; Berkman, 2006）。

护理机构存在多种类型，从提供日间的钟点护理到全天24小时住家护理一应俱全。在成人日托机构（**adult day-care facilities**），老年人只能在日间得到照顾，晚上和周末则在家里度过。在成人日托机构中，人们可以获得照料、进餐并按时参加活动。有时，这些成人日托机构还会与婴幼儿日托项目相结合，这样就可以让老年人和小孩子进行互动，从而增进健康（Tse & Howie, 2005; Gitlin et al., 2006; Dabelko & Zimmerman, 2008）。

还有些机构能够提供更全面的照料。最精细的护理机构是专业护理机构（**skilled-nursing facilities**），它能为患慢性疾病的老人和短期患病后逐渐恢复的老人提供全日护理。事实上，虽然65岁及以上的老人只有4.5%会住在护理院中，但其中年龄越大的人占比越高：65岁以上的老人占3%，85岁以上的老人则占10%（Administration on Aging, 2010; Nursing Home Data Compendium, 2013）。

护理机构的照料越精细，对居住者的适应性要求也就越高。虽然一些新入住的老年人能很快适应，但由此带来的自主性丧失也让很多老年人出现适应困难。另外，一些老年人也会受到人们对养老院刻板印象的影响，他们可能会因此对养老院抱有消极的预期。因为他们可能会觉得自己仅仅是在坐等死亡，而已经被一个崇尚年轻的社会遗忘和抛弃了（Baltes, 1996; Natan, 2008; Kostka & Jachimowicz, 2010）。

制度主义和习得性无助 尽管生活在护理机构中的老人们可能夸大了自己的恐惧，但这种恐惧仍然催生了制度主义（**institutionalism**），这种制度主义部分源于习得性无助，会使人们逐渐变得冷漠、无情和忽视自我需要。（Peterson & Park, 2007）。

这种由制度主义引起的无助感，确实会产生严重后果。例如想象一下，当老人住进养老院时，他们就失去了对自己最基本活动的控制权。他们被规定什么时候吃饭、吃些什么、什么时候睡觉，甚至连洗漱时长都被规定了，这会给个体带来严重的控制感丧失的感受（Wolinsky,

Wyrwich, & Babu, 2003; Iecovich & Biderman, 2012; de Oliveira Brito et al., 2014)。

一个经典的实验表明了这种控制感丧失所带来的后果。心理学家兰格和欧文·詹尼斯 (Irving Janis) 在1979年的实验中把住在养老院的老年人分为两组。他们鼓励其中一组被试对自己的日常生活做出各种选择；另一组则没有选择，并鼓励他们任由养老院的职员照顾。结果显示，有选择权的被试更快乐且健康。18个月后，有选择权的这组只有15%的被试去世，而另一组有30%的被试去世了。

简而言之，丧失控制权对个体的生活幸福感有着严重的影响。好的养老院会尽力允许入住者做一些关于基本生活的决定，让他们对自己的生活有一种控制感。

从医疗保健工作者的视角看问题

养老院可以采取什么样的措施来减少入住者的“制度主义”心理？为什么这种措施不常见？

财务、工作与退休

学习目标9.15 讨论老年人的经济保障，以及成年晚期的工作和退休带来的社会和经济差异。

接下来我们将讨论美国老年人的经济保障，以及工作和退休给他们带来的影响。

成年晚期的经济状况 成年晚期的个体与其他生命阶段的个体一样，社会经济状况有好有差。



个体在成年晚期的社会经济福利差异反映了早期生活情况的差异。

不过，不同群体在早年经历过的不公平会在晚年时更加突显。同时，随着人类寿命的不断延长，成年晚期个体所承受的经济压力也会不断增加，因为人们很可能会提前把积蓄用完。

大约10%的65岁及以上的老年人处于贫困状态，这个比例与65岁以下人群中的比例相当接近，另外约有6%的老年人处于接近贫困的状态（见图9-11）。不过，贫困情况在不同种族和性别中存在明显差异。生活在贫困之中的女性人数几乎是男性的两倍。独立生活的老年女性，有近1/4生活在贫困线以下。丧偶的已婚女性也可能会变得贫困，因为她可能在丈夫生前患病时就用完了所有的积蓄，而丈夫的养老金也在他去世后停止发放了（Spraggins, 2003; Administration on Aging, 2010）。

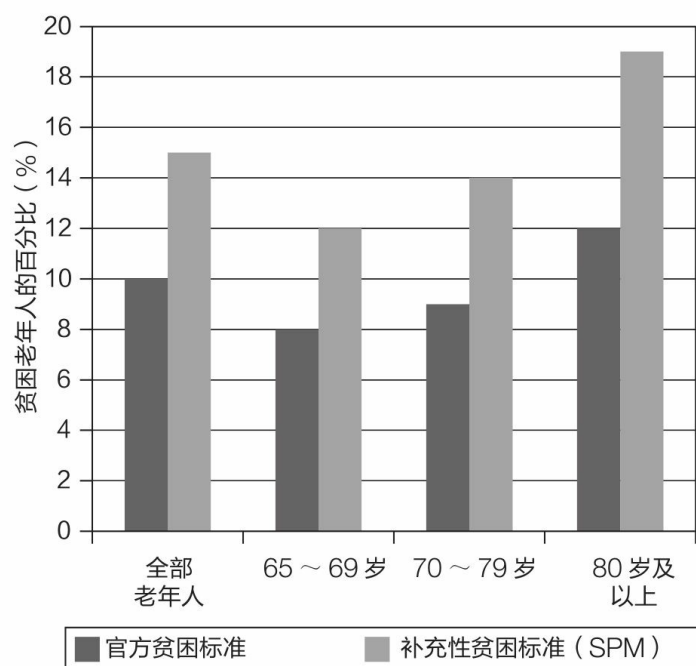


图9-11 贫困和老年人

在65岁及以上的老年人中，有10%的人生活贫困。补充性贫困标准是一种相对于传统美国贫困标准来说更新的标准，多数专家也认为这一标准的准确性更高。

资料来源：Kaiser Family Foundation Analysis of Current Population Survey, 2014 Annual Social and Economic Supplement.已被许可使用。

从种族差异来看，8%成年晚期的白人生活在贫困线以下，而同年龄段19%的拉丁裔和24%的非裔美国人生活在贫困中。少数族裔女性可能是处境最恶劣的群体。例如，65~74岁离婚的黑人女性中，贫困人数占到了47%（Federal Interagency Forum on Age-Related Statistics, 2000; U.S. Bureau of the Census, 2013）。

成年晚期个体陷入经济困境的原因之一，是他们只能依赖固定收入来支撑生活。老年人的主要收入来自社会保障、退休金和积蓄，而这些收入的积累几乎跟不上通货膨胀的速度。如此一来的结果就是，即使一个人在65岁时拥有非常不错的收入，这些储蓄的价值在20年后也可能会大幅降低，因此老年人就变得越来越穷。

医疗卫生保健费用的上升是老年人陷入经济困境的又一原因。老年

人在医疗卫生保健方面的平均花费是其收入的20%左右。那些住在护理机构中的老年人，其经济支出更令人吃惊，他们每年的平均医疗卫生保健费用在80 000美元以上（MetLife Mature Market Institute, 2009）。

除非社会保障和医疗保险在融资方式上出现重大改变，否则年轻公民将会缴纳更多的税款来作为老年服务的资金。这种情况势必会增加两辈人之间的矛盾和隔阂。事实上，正如我们接下来要看到的，社会保障费用成了人们决定工作年限的关键因素之一。

成年晚期的工作和退休 “布洛迪夫人，别忘了你的零钱，”吉姆·哈迪提醒他的顾客，“祝你和来家里的孙辈们过得开心。”哈迪边说边挥手告别，布洛迪夫人也微笑着挥手回应。

哈迪上个月就已经84岁了，但他仍旧每周在当地的超市工作24小时。“我以前不是收银员，”他说，“我这辈子先后在温哥华和缅因州做过很多工作，最开始是采伐作业，然后结婚后太太希望我找一份固定工作，我就在一家电话公司找到了维修的工作，一干就是40多年。”

妻子在5年前去世后，哈迪开始考虑退休，并移居到了夏威夷。“这里的城市非常美丽，居民也非常热情。”但是他没有退休，而是换了份超市的工作。

“我喜欢这里，”他说，“我可以见到很多人并和他们聊天。要是不工作了，我不知道自己应该做些什么。”

在什么时候退休是很多成年晚期个体面临的重大决定之一。有些人希望能尽可能地工作更久，其他人则会在经济条件允许时就退休。

不过当真正退休时，人们往往很难适应从“工作者”到“退休者”的身份转变。他们没有了职业的头衔，也不再有人向他们寻求建议，而且他们不能再说“我在钻石公司工作”之类的话。

但对另一些人来说，退休可能为他们提供了成年后第一次过悠闲生活的机会。大多数人早在55岁或60岁时就退休了，而人们的寿命又在不断

断延长，因此很多人的退休后时间比上几代人都要长。此外，由于老年人口的不断增加，退休人群作为美国人口的一部分，其影响力也越来越大了。

老年工作者：反击老年歧视 即使在成年晚期，很多人也会继续全职或兼职工作。他们能够这样做，主要得益于美国1975年通过的《禁止就业年龄歧视法》（ADA），该法律条文表明，几乎在所有行业中规定的退休年龄都被看作是不合法的（Lindemann & Kadue, 2003; Lain, 2012）。

无论是因为喜欢工作带来的智力和社会性回报，还是出于经济原因而工作的老年人，他们继续工作时都常常会遭到年龄歧视，尽管这在法律上是被禁止的，但这就是事实。一些雇主会鼓励老年人离职，从而用薪酬低的新人来替代他们。而且，一些雇主认为老年人已经无法胜任工作，也难以适应变化的工作环境——这是法律也无法改变的对老年人的刻板印象（Bowen & Skirbekk, 2013）。



退休对每个人来说都是不同的旅程。有些人喜欢安静的生活，有些人则继续保持活跃并不断追求新的活动。你能解释为什么在很多国家中，人们的退休生活并未遵循脱离理论吗？

但事实上，我们很难证明老年人的工作能力会降低。在艺术、文学、科学、政治和娱乐等领域，老年人做出重大贡献的例子比比皆是。即使在法律允许规定退休年龄的少数行业中，例如涉及公共安全的行

业，也没有证据证明人们应该在某个特定年龄退休（Landy & Conte, 2004）。

尽管年龄歧视仍然是一个问题，但市场需求也许有助于降低其严重性。当出生于生育高峰期的人退休后，市场劳动力锐减，企业就可能会鼓励老年人继续工作或接受返聘。不过，对大多数老年人来说，退休仍然是普遍选择。

退休：过一种休闲生活 人们为什么退休？尽管看起来主要原因就是想休息，但其实还有很多原因。例如，有时候人们会在长时间工作之后觉得倦怠，他们需要缓和工作中的紧张感和挫败感，让自己从力不从心的感觉中跳出来；有些人退休是因为健康状况下降；还有些人是因为受到了雇主的劝说；另外，也有一些人早就计划着退休了，他们想利用多出来的闲暇时间旅游、学习或者享受天伦之乐（Nordenmark & Stattin, 2009; Petkoska & Earl, 2009; Müller et al., 2014）。

无论退休的理由是什么，人们都需要经历一系列的退休阶段。退休后人们的第一个时期是蜜月期，即刚退休的人会积极参加之前没空安排的各种活动，如旅行。第二个时期是清醒期，此时人们会觉得退休并不完全像自己所想的那样，因此他们开始想念工作时的刺激、同事情谊，但他们会发现自己已经很难再次忙碌起来了（Atchley & Barusch, 2005; Osborne, 2012; Schlosser, Zinni, & Armstrong-Stassen, 2012）。

第三个时期是重新定位期，此时人们会重新考虑自己的选择，开始参与全新而充实的活动。如果能成功度过这个阶段，个体就到了第四个时期，即退休平淡期，人们开始接受退休的现实，并对新的生活状态感到满足。但不是所有人都能到达这个时期，有些人在很长时间都处于清醒期。

第五个时期是退休的结束期。虽然对一些人来说，退休结束就意味着重返职场，但其实大多数人都会在退休的结束阶段出现体能的衰退。在这种情况下，人们的健康状况会变得很差，甚至不能独立生活。

显然，不是所有人都会经历这些阶段，而且上述顺序也并非固定。在很大程度上，个体对退休的态度来自他当初选择退休的理由。例如，一个因为身体状况不佳而被迫退休的人和一个期盼在一定年龄退休的人，其内心的体验是很不一样的。与之类似，喜欢自己工作的人和轻视自己工作的人，退休后的感受也会不同。

简而言之，退休对个体心理的影响因人而异。对很多人来说，退休是美好生活的延续。此外，正如“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏所述，人们可以做很多事来规划美好的退休生活。

成为发展心理学知识的明智运用者 规划完美的退休生活

哪些因素能够创造出美好的退休生活？老年学家认为有如下几点（Borchard, 2008; Noone, Stephens, & Alpass, 2009; Wöhrmann, Fasbender & Deller, 2016）：

- 事先做好财务计划。社会保障金在未来很可能会不够用，你要有足够的个人积蓄，并给自己安排好健康保险。
- 逐渐从工作中退出。有时，从全职工作转为兼职可以帮助你顺利适应退休生活。
- 在退休之前发掘自己的爱好。思考你为什么喜欢现在的工作，并考虑如何将这些东西迁移到闲暇的活动中。
- 如果你已婚或正与某人保持长期关系，那么可以和伴侣讨论一下你的理想退休状态。你会发现你需要和伴侣协商出一个适合双方的愿景。
- 考虑你想住在哪里。试着在你想要居住的社区短住几天。
- 不要与儿女和孙辈住得太近。如果与孙辈住得太近，你可能会变成全职婴儿保姆——这可能符合你对退休的展望，也可能不符。
- 计划参与志愿活动。退休人员有多种技能，往往是非营利性组织和小企业所需要的。诸如退休老年志愿者计划（Retired Senior Volunteer Program, RSVP）或寄养祖父母计划（Foster Grandparent Program, FGP）这样的组织既能让你的技能派上用场，也能帮助有需要的人。

关系：旧的和新的

94岁的莱纳德说起了他和如今已经90的妻子埃伦相遇的情形。

“23岁那年珍珠港事件爆发，我当即应征入伍。我被派往布拉格堡，当时非常孤独，所以经常去费耶特维尔闲逛。有一天，我在一家书店找一本书，你还记得书名吗？”

“《沉寂的星球》（*Out of the Silent Planet*），”埃伦说，“我刚好也伸手拿那本书，我们的手碰到了一起，然后是目光。”

“那是我单身生活的终点，”莱纳德说，“命运把我带到了那家书店。”

埃伦说：“从那时起，我们分享了那本书和以后所有的事情。4个月后我们就结婚了。”

“直到战争结束，我离开布拉格堡。”莱纳德说。

这就是他们相处的方式：他起一个话头，她来完成。或者是倒过来。

“她天天给我写信，我都是整摞整摞地收，那是我读过的最好的信。”他把手放到埃伦的膝盖上，而她也把手放在他的手上。

“你可不常给我写信，”她温柔地提醒，“但是我一收到你的信，就每天都会读。”

“我也是啊！”他笑着说。

莱纳德和埃伦之间的温情显而易见。他们的关系已经维持71年了，还是那么和谐，这让他们的生活平静而快乐，也足以让很多夫妇艳羡。但这种生活对成年晚期的人来说也很少见。相比有伴侣陪伴的老年人，更多的是孤独的老年人。

想要知道成年晚期个体的社会生活状态，我们可以先从探讨婚姻开始。

晚年的婚姻：从彼此相伴到孤身一人

学习目标9.16 找出夫妻在成年晚期会面临的问题，并描述丧偶带来的挑战。

65岁以后，处于已婚状况的男性比例远高于女性（见图9-12）。原因之一是70%的女性在丈夫去世后还能活好几年，但男性却因为很多都已经去世而大大减少了数量，所以这些女性也不太可能再婚了（Barer, 1994）。

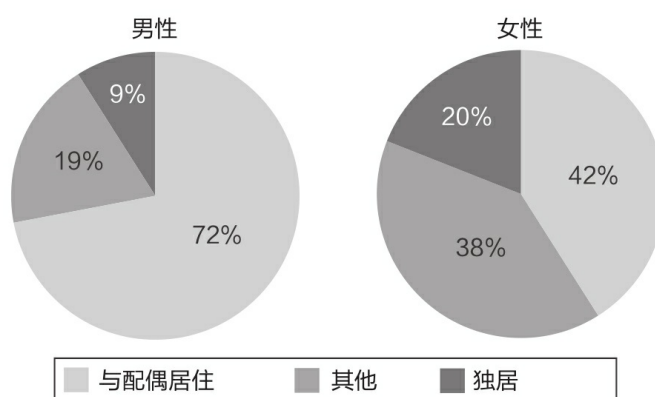


图9-12 美国老年人的居住模式

关于老年男性和女性的相对健康状态和适应情况，这些模式说明了哪些内容？

资料来源：Administration on Aging, 2006.

此外，我们之前讨论过的婚姻梯度也是导致以上情况的重要因素。在婚姻梯度这一社会标准的影响下，女性通常要和比自己年龄大的男性结婚。于是晚年时，女性往往只能孤单地生活。同时，婚姻梯度使男人再婚很容易，因为那时适合他们结婚的对象更多了（AARP, 1990）。

绝大多数在生命晚期仍然是已婚的人都说他们对自己的婚姻很满意。伴侣为他们提供了大量的友谊和情感支持，因为到了生命的这个时期，他们往往已经在一起很长时间了，而且对自己的伴侣都有着很深的了解（Levenson, Carstensen, & Gottman, 1993; Jose & Alfons, 2007）。

同时，并不是婚姻的任何一方面都能令人满意，当配偶经历生活中的转变时，其婚姻就可能会面临严重的压力。例如，婚姻中的一方或双方的退休会改变夫妻关系（Henry, Miller, & Giarrusso, 2005）。

离婚 有些夫妇会因为各种各样的压力而选择离婚。尽管没有确切的数据，美国66岁以上离婚的女性也至少有12%，这是20世纪80年代数据的3倍（Brown & Lin, 2012; Ellin, 2015）。

晚年离婚的原因有很多。通常，女性离婚是因为丈夫有虐待或酗酒行为，而男性要求离婚则是因为他们找到了一个更年轻的女人。晚年离婚往往发生在退休后不久，此时，那些一直潜心于工作的男性正处于心理混乱之中（Franz et al., 2015）。

在生命晚期离婚，对女性来说会面临巨大的挑战。在婚姻梯度标准和适婚男性数量很少的双重不利条件下，年纪大的离异女性不太可能再婚。对很多女性来说，婚姻中的角色可能是其一生中的主要角色和核心身份，她们会把离婚看成人生的巨大失败。因此，晚年离异女性的生活质量和幸福感会骤然下降（Davies & Denton, 2002; Connidis, 2010）。

寻求一段新的关系可能是很多离异或丧偶老人的首要任务。努力发展新关系的人们，会利用与年轻人相同的策略去认识潜在的伴侣，如参加单身组织，甚至用互联网去寻觅伴侣（Durbin, 2003）。

当然，有些人在进入成年晚期时还从未结过婚，他们大概占成年晚期人口的5%。对这些人来说，成年晚期的改变并不多，因为他们的居住状态并没有改变。事实上，一直保持单身的人在年老时会比大多数同龄人更少感到孤单，因为他们有更强烈的独立感（DePaulo, 2006）。

应对退休：两人在一起的时间太多了吗 当莫里斯·阿伯克伦比终于停止全职工作时，他的妻子罗克珊觉得他在家的时间太多了，反而给生活添了很多麻烦。虽然他们的婚姻关系很好，但莫里斯开始干涉她的日常活动，不断追问她和谁打电话、刚才到哪里去了，这都让她不满。

最后，她开始希望莫里斯在家的时间能少一些。这个想法很有讽刺意味：因为莫里斯需要全职工作的时候，罗克珊曾经希望他能有更多时间在家陪自己。

莫里斯和罗克珊的这种问题并不是个例。对很多退休夫妇来说，他们之间的关系需要重新协调，因为此时夫妻待在一起的时间比之前的任何时候都多。对另一些人来说，退休改变了夫妻双方长期以来的家务分配，丈夫开始承担更多的日常家务。

研究表明，这时夫妻双方通常会有一个有趣的角色倒置。与婚姻早期相反的是，在成年晚期，丈夫会比妻子更渴望与配偶在一起。婚姻的权力结构也转变了，男性退休后会变得更有亲和力且更少竞争，女性则会变得更加果断和自主（Williams, Sawyer, & Allman, 2012）。

照顾年老的配偶 随着成年晚期个体身体状况的改变，有时人们需要用前所未有的方式来照顾配偶。例如，一位心灰意冷的妻子这样说：

我哭了很多次，因为从没想到情况会是这样的。我从没想过要打扫浴室，替他换衣服，整天洗衣服。我在20多岁时这样照顾过婴儿，现在我这样照顾丈夫（Doress, Siegal, & The Midlife and Old Women Book Project, 1987, pp. 199-200）。

同时，有些人会将照料病重或垂死的配偶看作是表达自己爱与奉献的最后机会。事实上，一些看护者会感到很开心，因为他们觉得自己能担负得了对配偶的责任。而那些最初经历过情绪困扰的人，也会随着发现自己能成功地适应照料工作，而使不愉快的情绪逐渐消退（Kulik, 2002）。

但我们不能否认，照顾配偶的确是一项耗费精力的工作。更糟糕的是，看护者的自身身体状况可能也不如以前了。实际上，这样的照顾可能对看护者的生理和心理健康都有不利影响。例如，多数看护者曾自陈

对生活的满意度低于不用照顾别人的人（Choi & Marks, 2006; Percy, 2010; Mausbach et al., 2012）。

值得关注的是，向配偶提供照料的人中有3/4是女性。原因之一和人口状况有关：男性通常早于女性死亡，那他们患上致命疾病的时间也一般早于女性。另一个原因与社会对性别角色的传统看法有关，社会普遍认为女性是“天生的”看护者，所以卫生保健专业人员更倾向于建议妻子照顾丈夫，而不是丈夫照顾妻子（Khalaila & Cohen, 2016）。

配偶的死亡：成为寡妇或鳏夫 几乎没有什么比丧偶更让人感到悲痛的事情了。特别是对年轻时就结了婚的人来说，配偶的去世不仅会给人们带来巨大的丧失感，还会造成健在配偶经济和社会环境上的重大改变。如果这对当事人来说是一段美好的婚姻，那么配偶的去世就意味着其失去了一个伴侣、爱人、知己和帮手。

伴侣去世后，健在的那一方要突然接纳一个新的、自己并不熟悉的身份：寡妇或鳏夫。同时，他们也丢掉了自己最熟悉的角色：他人的配偶。突然，他们不再是夫妻中的一方了，他们开始被社会和自己看作是单独的个体。而这些又都发生在他们刚刚面对几乎是压倒一切的巨大悲痛时，我们将会在接下来的内容中进一步讨论。



个体在成年晚期最艰难的责任之一是照顾患病的配偶。

寡居会给个体带来很多新的生活要求和担忧。再也没有伴侣可以和他們分享每天发生的事情了。如果以前都是已故的配偶在承担主要的家务活，那么现在夫妻中健在的一方就必须学会做这些家务，而且要天天做。虽然家人和朋友能为其提供大量的支持，但这些帮助会逐渐减弱，最后只留下新寡或新鳏的人独自适应生活（Hanson & Hayslip, 2000; Smith, 2012）。

人们的社会生活往往会因配偶的死亡而发生巨变。例如，如果一对夫妇此前常与另一对夫妇来往，那么鳏寡个体现在在继续保持和原来那些夫妇共同筑起的友谊时，就会感觉自己像汽车的“第五个轮子”一样碍眼。最终，那样的友谊会慢慢衰退，也可能会由他们与其他单身个体建立的新友谊所代替（Bookwala, 2016）。

经济问题是很多鳏寡个体面临的难题之一。尽管很多人有保险、积蓄和退休金来为自己提供经济保障，但一些个体，通常是女性，在配偶去世后会体验到经济状况下滑的窘境。在这种情况下，经济状况的改变会迫使人们做出痛心的决定，例如卖掉夫妻俩此前共同居住的房子（Meyer, Wolf, & Himes, 2006）。

个体适应寡居的过程分为三个阶段。第一个阶段是准备期（preparation），夫妇中的任何一方都要做好面对配偶最终都会去世的准备，有时甚至要提前几年甚至几十年。此时要考虑很多事情，例如买人身保险、准备遗嘱、决定养孩子以便将来老有所依等。这些都是为将来自己变成鳏寡个体要做的准备，而且在这个过程中，人们也会需要一定程度的社会帮助（Roecke & Cherry, 2002）。

第二个阶段是悲痛和悼念期（grief and mourning），这是健在一方在配偶去世后的即时反应。他们首先要承受丧偶给自己造成的痛苦和打击，继而要渡过丧偶带来的一个情绪起伏阶段。个体渡过这个阶段所需的时间，取决于其他人给予支持的程度以及个人的人格特征。有些人的悲痛和悼念期会持续几年，而有些人则只持续几个月。

适应配偶去世的第三个阶段是适应期（adaptation）。在这个阶段中，鳏寡个体要适应新的生活。他们会开始接受配偶的死亡标志着新阶段的开始这一事实，然后他们就会以一个新的角色生活，并建立新的友谊。适应阶段中还包括一段整合期，这一时期个体会发展出“单身者”这一新的同一性。

当然，丧偶三阶段的模型不一定符合每个人的情况，各阶段的持续时间因人而异。而且，一些人会经历复杂性哀伤（complicated grief）。这是一种不屈不挠的悼念，会持续数月甚至数年。在这一时期，人们很难放下曾经的爱人，他们对死者的记忆会侵蚀日常的思考，从而影响到正常的身心功能（Holland et al., 2009; Piper et al., 2009; Zisook & Shear, 2009）。

但是，对于多数人来说，丧偶后生活会逐渐恢复正常，并重新变得愉快。尽管如此，丧偶在个体的生命任何阶段发生，都无疑是一个重大事件。在成年晚期，其影响对个体来说尤为严重，因为配偶的死亡可能预示着自己也将不久于人世了。

从社会工作者的视角看问题

哪些因素共同造成了成年晚期的生活对女性来说比男性更困难的现象？

成年晚期的朋友和家庭

学习目标**9.17** 找出对老年人来说重要的人际关系，并解释它们为什么重要。

老年人和年轻人一样喜欢结交朋友，友谊在成年晚期的生活中也占据重要地位（见图9-13）。事实上，相比和家人在一起，人们在晚年甚

至把与朋友在一起的时间看得更重要，因为朋友是比家人更有力的社会支持来源。另外，大约有1/3的老年人在自我报告中说自己在最近一年里建立了一段新友谊，还有很多老年人会经常参与重要的社会交往活动（Ansberry, 1997; Bookwala, 2016）。

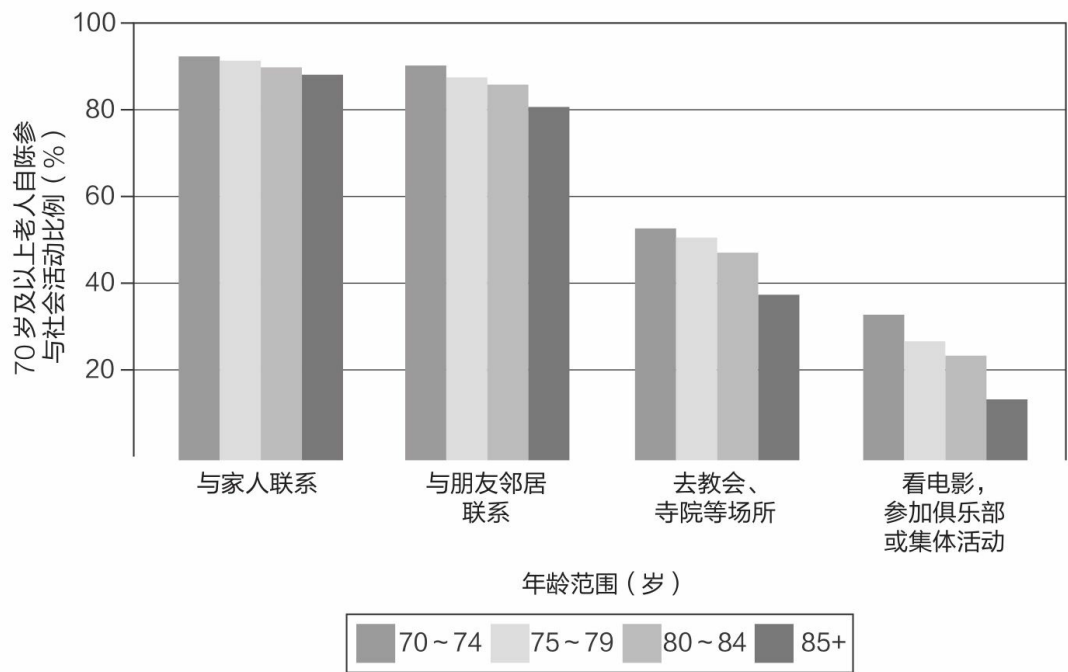


图9-13 成年晚期的社交活动

朋友和家人在老年人的社会生活中占据重要地位。

资料来源：Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2000.

友谊：为什么朋友在成年晚期很重要 首先，友谊以控制感为特征：不同于家庭关系，在友谊关系中，我们能选择自己喜欢谁或不喜欢谁，并决定是否在一起。因为老年人在健康等其他方面的控制感逐渐丧失，所以此时维持友谊的能力可能比在生命中的任何时期都重要（Demir, Orthel, & Andelin, 2013; Singh & Srivastava, 2014）。

其次，友谊——特别是新建立的友谊可能比家庭关系更灵活，因为新建立的友谊没有长期的责任和冲突问题，而这种问题往往是家庭关系的典型特征，也是减少家庭成员之间感情支撑的源头（McLaughlin et

al., 2010; Lester et al., 2012)。

最后，随着年龄的增长，人们更可能失去婚姻伴侣，而友谊对成年晚期的个体来说就变得很重要。配偶去世后，多数人会寻求朋友的陪伴，以帮助自己应对丧偶的痛苦，并弥补配偶去世带来的关系中的缺失感。

当然，一个人到了老年期，他的朋友们也可能会像配偶那样提前离世。成年晚期的人们看待友谊的方式，决定了他们在多大程度上能够承受朋友去世带来的打击。如果一份友谊被看作是不可替代的，那么失去某位朋友就会让人感到非常难过；但如果一份友谊只是当事人众多友谊中的一部分，那么某位朋友的过世对他的打击就没有那么大（Bleiszner, 2006）。

友谊也能为人们提供基本的社会需要之一，即社会支持。社会支持是指由体贴、热心的人组成的社会关系网为相应人群提供的帮助和安慰。这些支持对顺利老化非常重要（Avlund, Lund, & Holstein, 2004; Gow et al., 2007; Evans, 2009）。

社会支持的效用相当巨大。首先，社会支持网可以通过表达同情和为个体所关注问题提供建议来给相应人群以情感支持。其次，面临配偶去世等同样情境的人能对当事人的处境报以极深的理解，并为其提供很多应对困难的有效建议，这些人的建议往往比其他人更可靠。

最后，社会支持还包括他人的物质支持，比如载你一程或帮你买些副食品。面对实际困难时，社会关系中的他人也能够帮上忙，如帮你与难缠的房东交涉、修理电器等。

社会支持不仅对接受者有好处，对提供者也是有益的。提供帮助的人知道自己正在为他人的幸福而做出努力，他们也会因为自己提供了价值而提高自尊。

什么样的社会支持最有效、最恰当呢？其实有很多，比如为别人准

备食物、陪别人去看电影或邀请别人共进晚餐。然而，创造机会进行互惠也很重要。互惠指的是如果一个人对另一个人提供过积极的支持，那么提供者就会期待以后对方也能对自己有所帮助。在许多社会里，老年人和年轻人一样，都比较看重有互惠潜力的关系。不过，随着年龄的增长，一个人要回报别人给予的社会支持可能会逐渐变得困难。这就会导致老年人与别人的关系变得越来越不对称，接受帮助的人往往陷于进退两难的心理状态（Becker, Beyene, & Newsom, 2003）。

家庭关系：联系的纽带 即使在配偶去世后，很多老年人仍然是大家庭里的一员。他们仍然和兄弟姐妹、儿女、孙辈甚至曾孙辈保持着联系，这些人是个体晚年生活中重要的安慰来源。

在成年晚期，兄弟姐妹通常能够彼此提供很强的情感支持，因为他们可以经常分享旧时童年中的美好记忆，而且这种联结通常代表着一个人最早的现存关系。虽然并不是所有人的童年记忆都很愉快，但在晚年期间保持与兄弟姐妹来往能为个体提供一种巨大的情感支持（Moyer, 1992）。

子女 对成年晚期个体来说，比兄弟姐妹更重要的是子女和孙辈。虽然现在搬迁率很高，但无论是地理位置上还是心理上，多数父母和子女之间的联系仍非常紧密。在美国，大约75%的儿女的住所与父母的住所相隔在30分钟车程以内，父母和子女们会经常彼此探望和聊天。女儿似乎比儿子更常联系父母，母亲则比父亲更常收到儿女的信息（Shen, Zhou, & Tong et al., 2003; Diamond, Fagundes, & Butterworth, 2010; Byrd-Craven et al., 2012）。

对大多数老年人来说，一般至少会有一个孩子住得离自己比较近，所以家庭成员往往总能为彼此提供大量的帮助。此外，父母和子女对成年子女应该如何对待父母的看法比较一致（见表9-2）。较为突出的是，父母往往预期子女应该帮助父母了解自己的现有资源、为自己提供情感支持，并深入讨论一些医疗问题等重要事情。另外，常见的情况

是当年老的父母需要照料时，子女会尽责地照料年老的父母

（Dellmann-Jenkins & Brittain, 2003; Ron, 2006; Funk, 2010）。

有时父母和子女之间的联系并不对称，父母想要更加紧密的联系，但子女却希望彼此疏远一点。父母在和子女的联系中会给予更多的发展投资（developmental stake），因为他们把子女看作是自己信念、观念和准则的延续，而子女则更想要独立，并不愿依赖父母。这些视角的差异使父母更有可能把他们和子女之间的矛盾缩小，而子女则更有可能把矛盾扩大。

孙辈和曾孙辈 正如我们之前所讨论的，祖父母对孙辈生活的参与程度高低不一。即使那些非常以孙子女为荣的祖父母，也会和孙子女保持一定的距离，以避免承担直接的照料责任。但是，很多祖父母会把孙子女作为他们社交网络中重要的一部分（Coall & Hertwig, 2010, 2011; Geurts, van Tilburg, & Poortman, 2012）。

正如我们所看到的那样，祖母比祖父更愿意参与孙辈们的生活，多数成年不久的孙辈可能也会觉得和祖母更亲。另外，他们往往会觉得外祖母比祖母更亲（Hayslip, Shore, & Henderson, 2000; Lavers-Preston & Sonuga-Barke, 2003; Bishop et al., 2009）。

非裔美国人祖父母相比白人祖父母，会更多地参与孙辈们的生活，而且相对白人孙辈们来说，非裔美国人孙辈们会感觉与祖父母更亲。此外，相对白人祖父来说，非裔美国人祖父在孙辈生活中会处于更加核心的地位。这一种族差异可能是研究样本中的非裔美国人多代家庭的比例大于白人所致。在多代家庭里，祖父母通常在儿童教养中扮演核心角色（Crowther & Rodriguez, 2003; Stevenson, Henderson, & Baugh, 2007; Gelman, Tompkins, & Ihara, 2014）。

曾孙在白人和非裔美国人曾祖父母生活中的地位都不那么重要，大多数曾祖父母和曾孙的联系也并不太密切。密切的关系只有在两者住得比较近的时候才会出现（Roberto & Skoglund, 1996; McConnell,

2012)。

曾祖父母和曾孙之间联系相对不紧密主要有两个原因。一是当人们有曾孙辈时，其实已经没那么多体力和精力来与曾孙相处了。二是可能曾孙的人数太多了，以至于曾祖父母感觉与他们之间没有太强的情感联系，有时甚至难以了解他们。当肯尼迪总统的母亲、生了9个孩子的露丝·肯尼迪在104岁去世时，她有30个孙子女和41个曾孙子女！

不过，仅仅是有曾孙这样一个事实，也能让曾祖辈感到很高兴。例如，他们会觉得曾孙们是自己及家庭的延续，同时也说明了自己的长寿。而且，随着个体成年晚期健康条件的不断提高，曾祖父母的身体状况也能让他们更多地参与曾孙子女的生活（McConnell, 2012）。

虐待老人：变差的关系

学习目标9.18 讨论哪些因素导致了老人被虐待，以及如何预防这种现象。

邓普顿74岁的时候，她的儿子亚伦搬来和她同住。“我很孤独，也欢迎他来陪我。当他提出管理我的存款时，我也答应了。”

3年来，亚伦兑完了她的支票，取光了她的存款，还用了她的信用卡。“当我发现时，亚伦向我道歉，说他需要钱摆脱麻烦，而且答应马上停下来。”

但其实亚伦并没有住手。他花光了邓普顿账户里所有的钱，紧接着又向她索要她保险箱的钥匙。她拒绝了，亚伦就打她，直到她失去意识。

“造成他这样的原因是吸毒，”邓普顿说，“最后，我把警察叫来，逮捕了他。现在我感受到了这些年来从未有过的自由。”

很多人可能会觉得这种事情应该比较少见，但其实它远比我们想象

的普遍。虐待老人（**elder abuse**），指的是对老人身体上或心灵上的虐待或忽视。据估计，一年中约有11%的老人受到了某种形式的虐待或潜在的忽视。这个估计甚至有可能太保守了，因为受到虐待的人通常会因为感到难堪和羞耻而不愿意报告自己的困境。而且，随着老年人数目的不断增长，专家认为虐待老年人的情况仍在增加（Acierno et al., 2010; Starr, 2010; Dow & Joosten, 2012）。

虐待老人的案例通常发生在家庭成员之间，尤其是年老的父母更可能成为受害者。那些健康状况差、孤单的老人以及和看护者同住的老人更有可能遭受虐待。尽管导致人们虐待老人的原因有很多，但通常是在必须全天陪护的情况下，看护者所承受的较大经济、心理和社会压力催生了这些行为。因此，患有阿尔茨海默病或其他重度神经认知障碍的人，更有可能成为被虐待的对象（Baker, 2007; Lee, 2008; Castle & Beach, 2013）。

应对虐待老人的最好方法就是防止其发生。照顾老年人的家庭成员应当适时地休息一下，也可以在需要的时候联系当地社会支持机构，他们往往能为看护者提供建议和具体的支持。当怀疑有老年人受到虐待时，可以联系当地的权威机构和政府。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标9.10 列出并描述有关成年晚期人格发展的各种理论。

埃里克森把老年期称为自我完善对失望阶段，佩克关注定义该时期的三个任务，莱文森认为老年人可以体验到解放和自我关注，钮加藤则关注人们应对老化的方式。

学习目标9.11 解释年龄与资源、力量及特权的分配之间的关系。

年龄阶层理论认为，经济资源、力量和特权的分配不均衡现象在成年晚期尤为严重。整体上，西方社会对老年人的尊重程度不如许多亚洲社会。

学习目标9.12 对智慧下定义，并描述它与年龄有何关系。

智慧是有关人类行为的知识积累的结果。由于智慧是从经验中获取的，所以它可能与年龄有关。

学习目标9.13 找出各种衰老理论之间的区别，并解释文化如何影响人们对待老年人的方式。

脱离理论认为，老年人会逐渐从外界活动中退出；而活跃理论则认为最快乐的老年人是继续参与外界活动的人。连续理论这个较为折中的理论可能是关于顺利老化的最有用的观点，而衰老的最成功的模型可能是通过补偿行为达到选择性最优化。那些尊重老年人的社会，其特点是社会同质性高、存在大家庭、老年人责任重大以及他们拥有重要资源的控制权。

学习目标9.14 描述为老年人安排住所的可能方式，并解释每种方式会如何影响他们的生活质量。

老年人有各式各样的居住环境。有些人会和家人住在一起，有些人则会住在从连续照料社区到专业护理机构等不同照料级别的专门机构中。与配偶一同生活代表着老年人可以延续过往的生活状态，而搬到子女家中和多代人同住则可能是一项挑战。生活在护理院或其他机构性环境中会导致自主性丧失，这是让许多老年人感到恐惧的事情。

学习目标9.15 讨论老年人的经济保障，以及成年晚期的工作和退休带来的社会和经济差异。

经济问题会让老年人陷入困境，多数原因是他们的收入是固定的，

而健康支出却在不断增长，同时人类的寿命也在延长。许多人退休后会经历下列阶段：蜜月期、清醒期、重新定位期、退休平淡期和结束期。规划好退休生活的方式有很多，包括从工作中慢慢抽身、在退休前挖掘一些兴趣爱好、提前做好财务规划等。

学习目标9.16 找出夫妻在成年晚期会面临的问题，并描述丧偶带来的挑战。

虽然个体到了成年晚期时婚姻通常是愉快的，但这一时期的许多变化也可能会产生导致离婚的压力。配偶死亡会给健在的一方带来巨大的心理、社会 and 物质上的影响，这也使得建立和维持友谊对健在的一方来说尤为重要。

学习目标9.17 找出对老年人来说重要的人际关系，并解释它们为什么重要。

成年晚期的个体会高度重视友谊，这也是社会支持的重要来源。在多数老年人的生活中，家庭关系仍然是一个重要部分，特别是个体与兄弟姐妹及子女的关系。这些关系可以为成年晚期的个体提供情感支持。

学习目标9.18 讨论哪些因素导致了老人被虐待，以及如何预防这种现象。

缺乏社交、健康状况差的老人可能被不得不承担看护者角色的子女虐待。应对虐待老人现象的最好方法，就是通过让看护者获得休息时间和社会支持来防止其发生。

自我检测

1. 根据埃里克森的观点，处于成年晚期的个体会回顾过去的生活，对其进行评价，最后达成妥协。这也被称为_____。

- a. 自我超越对自我专注
 - b. 接受对分离
 - c. 繁殖对停滞
 - d. 自我完善对失望
2. 顺利老化的模型包括_____。
- a. 补偿理论、脱离理论、最大化理论
 - b. 活跃理论、连续理论、选择性最优化
 - c. 能力理论、社会性理论、退缩策略
 - d. 社会最优化、补偿理论、生活事件理论
3. 人们从工作岗位退休后，通常会经过一系列阶段，包括_____。
- a. 蜜月期、清醒期、重新定位期、结束期
 - b. 定位错乱期、不满期、重新定位期、接受期
 - c. 活动增加期、迷惑期、重新投入期、结束期
 - d. 愤恨期、孤独期、重评期、满足期
4. 对丧偶进行适应的第一个阶段是_____。
- a. 适应期
 - b. 准备期
 - c. 愤怒期
 - d. 妥协期

应用于毕生发展

配偶的退休会通过哪些方式给婚姻带来压力？如果夫妻双方都工

作，那么退休带来的压力会减轻还是会加倍？

总结

彼得和埃拉住在一起，但是他们选择了不同的生活方式度过成年晚期。彼得喜欢宅在家里照料内务，埃拉则喜欢繁忙的退休生活，参加活动、聚会甚至工作。他们的共同之处在于，都在退休后致力于保持身体健康、智力活跃和维持重要关系。他们采取了完全不同的方式，但对这三方面需求的重视，让彼得和埃拉能始终保持着积极乐观的状态，并对生活的每一天都充满期待。

9.1 成年晚期的生理发展

- 尽管彼得和埃拉按实际年龄来看属于高龄老人，但他们按功能年龄来说还是年轻人。
- 他们都在健康和态度上挑战了人们对老年人的刻板印象。
- 他们好像都幸免于患上阿尔茨海默病或其他大多数与年龄相关的身心不适。
- 彼得和埃拉选择了运动、正确饮食、避免不良习惯的健康生活方式。

9.2 成年晚期的认知发展

- 彼得和埃拉的晶体智力显然很好。
- 他们通过刺激、练习和激励保持心智能力，证明了他们的可塑性。
- 他们都有有一些轻微的记忆问题，比如情境记忆或自传式记忆的衰退。

9.3 成年晚期的社会性和人格发展

- 彼得和埃拉处在埃里克森理论自我完善对失望阶段，但是他们似乎选择了不同的答案来完成佩克提出的自我重新定义对沉迷工作角色的任务。
- 从钮加滕的人格分类理论看，他们应对老化的方式是不同的。
- 他们都随着年龄的增长获得了智慧，知道自己是什么样的人，应该如何与别人相处。
- 彼得没有参与竞技活动或读书俱乐部，这是为了对反应减慢或回忆能力下降做出补偿。
- 他们兄妹俩都选择了在一个新家里营造新的生活。
- 彼得和埃拉似乎都没有经历退休生活的典型阶段。



退休顾问会怎么做？



你会给像埃拉那样总是想着工作的人什么建议呢？对于像彼得那样满足于悠闲退休生活的人，你又有什么建议呢？你会根据这些人的什么特征来给他们正确的指导并提供相应帮助呢？

医疗保健工作者会怎么做？



你认为，彼得和埃拉为什么会有这么好的身心健康状态呢？有什么埃

拉用了而彼得可能没有用的策略吗？有什么彼得用了而埃拉可能没有用的策略吗？他们共同使用了什么策略呢？

教育工作者会怎么做？



你会为彼得或埃拉推荐认知训练吗？你会推荐“马路学者”课程或大学在线课程吗？为什么推荐或者为什么不推荐呢？

你会怎么做？



如果让你做一个由彼得和埃拉进行的口述历史项目，你会期望他们的

记忆有多完整和精确呢？将20世纪60年代和21世纪前10年进行对比，你认为他们对哪个时间段的描述会更准确？你更喜欢和他们中的哪一个人聊天呢？

第10章 死亡和临终

68岁的爱丽丝·卡希尔已经早早做好了迎接死亡的准备。她在6个月前被检查出脑部长了肿瘤且无法做手术。爱丽丝已经为尚能自由活动的日子做好了充分的计划，好让她能以自己想要的方式离开人世，即通过一个美好的爱尔兰式守灵仪式，让亲人和朋友们齐聚一堂来纪念她的一生，而不是哀悼她的死亡。她希望在家中而非医院过世，并且希望依照传统习俗将自己的灵柩停放在客厅中。她邀请了一支小型室内乐队的三个朋友在守灵仪式上演奏，并且给了他们自己最喜欢的歌曲清单。爱丽丝抄写了自己最喜欢的诗歌，并请女儿朗读。最后，她在一家本地的餐厅预订了一份供200人就餐的外送菜单。这将会是一个盛大的派对。

在本书的最后一章讨论生命的终结真是再恰当不过了。我们会先讨论死亡的时刻是如何定义的，然后考察人们在生命的不同阶段对死亡的看法和反应。之后，我们会考察人们如何直面自己的死亡，我们会提到一个理论，即人们在确知自己时日无多时会经历不同的阶段。我们还会讨论人们如何通过生存意愿遗嘱和协助自杀来控制与死亡有关的情境。最后，我们会考察丧亲和悲痛，区分正常的和过度的悲痛，并讨论丧亲给个体带来的后果。我们还会了解一些与出殡和服丧有关的内容，讨论人们如何去接受深爱之人的逝世。

10.1 毕生发展中的临终和死亡

在定义死亡方面，有哪些道德和伦理问题？

10.2 面对死亡

“不必进行施救”，辅助自杀，安乐死……你的立场是什么？

10.3 悲痛及丧亲

悲痛和丧失之间的区别是什么？

10.1 毕生发展中的死亡和临终

好似一头恐龙

去年10月，当朱尔斯·贝克哈姆迎来百岁生日的时候，家人为他举办了一场盛大的派对。他回忆说：“我的孩子、孙子、重孙子都来了，加上两个还在妈妈肚子里的重孙女，我们一共有42个人。”而没能来到这场庆典的，有朱尔斯5年前因为癌症去世的长子，和一个因为交通事故丧生的孙女。同样缺席的，还有那所他教授了40年英语的中学里的前同事，他们都已不在这个世界上了。第二次世界大战时和他一起在太平洋上奋战的弟兄们，以及那些退休后和他一起下棋的朋友们也都先一步离开了。“我是活到最后的那个人。我爱我的家人，但他们尽管都已听我讲过无数遍我的往事，却从来都无法真正理解我所说的1960年以前的事究竟是怎样的。”他如是说。

朱尔斯已经拟好了生存意愿遗嘱，并把它交给了自己的长女和医生们。他说：“真是有趣。战时面对敌军的炮火时，我不得不终日都顽强对抗死亡的恐惧；而如今我却如此平静。我不想死，但我觉得自己就像一只恐龙⁽³¹⁾。我不想在我有了严重的脑损伤或瘫痪在床时，却仍要无谓地延长生命。如果说100年的时间教会了我什么，那便是生命的质量远比长度要珍贵得多。”



即使能活到百岁，死亡仍然是我们每个人的必经之途。正因如此，死亡就成了我们理解毕生发展的一个关键。

发展心理学近些年来才开始严肃地研究死亡对毕生发展的意义。在这一节中，我们将从几个不同的方面来探讨死亡和临终。我们首先来看看死亡的定义，它会比其字面意义更复杂。然后我们将考察人们在生命的各个阶段对死亡的看法和反应，并比较不同社会看待死亡时的差异。

理解死亡

在经历了一场浩大的法律和政治争论后，特丽·夏沃的丈夫终于能够摘掉维持了她生命15年的氧气面罩了。夏沃因为呼吸停止和心脏停搏引起了脑损伤，之后就一直处于“永久性植物人”的状态，这就意味着她永远不可能再恢复意识了。经过一系列的法庭激战，她的丈夫不顾岳父母的意愿，最终获准拔掉她的进食管。不久之后，夏沃就去世了。

夏沃的丈夫要求拔除她进食管的决定是否合理？当这根管子被拔掉的时候她是不是已经死去了？夏沃丈夫的行为是否忽略了她本人的合法权利？

这些难题确实表明了个体生与死这一主题的复杂性。死亡不仅是一个生物学的过程，它同样也包含了心理学层面的内容。我们不仅要考察死亡的定义，还要考察人们在生命的不同时期对死亡的看法是如何改变的。

定义死亡：生命何时终结

学习目标**10.1** 如何判定死亡。

什么是死亡？尽管这个问题看起来很好回答，但其实定义生命的终结是异常复杂的。随着科学的发展，一些在过去的几十年里被判定为己

经死亡的患者，用现在的标准来看，当时可能还活着。

功能性死亡（**functional death**）被定义为心脏停止跳动，呼吸停止。事实上，这个定义太模糊了，例如，一个心跳和呼吸都停止了5分钟的人可能会重新活过来并且几乎没有损伤，那么按照功能性死亡的标准来判定，现在这个活着的人岂不是已经死过一回了吗？

因为这个定义并不严密，所以心跳和呼吸已经不再作为医学界衡量死亡的标准，医学专家开始更多地通过脑功能对死亡进行测量。脑死亡（**brain death**）是指所有由电子仪器测量的脑电波活动都已经停止了。个体一旦被定义为脑死亡，其脑功能就没有再恢复的可能了。

但一些医学专家认为，将死亡仅仅定义为脑电波的消失未免过于狭隘。他们主张，一个丧失了思考、推理、感觉和体验世界能力的人也可以被宣告死亡。这种观点掺入了许多心理学的因素，一个遭受了难以修复的脑创伤、昏迷不醒或是无法再对人类生活有任何感知的人，即便他仍存在一些原始脑活动，也可以判定为已经死亡了（Ressner, 2001; Young & Teitelbaum, 2010; Burkle, Sharp & Wijdicks, 2014）。

以上观点将我们对死亡标准的思考从严格的医学角度转移到了道德和哲学层面，目前仍然存在很大争议。因此，尽管有一些法令在沿用依据呼吸和心跳停止来判定死亡的标准，但在美国绝大多数地方，医生仍然以脑功能的完全丧失作为法定死亡的判别标准。事实上，不管死亡在何地发生，人们都极少测量脑波。通常来说，只有在死亡时刻很重要、有可能进行器官移植或涉及犯罪和法律问题等一些特定场合下，人们才会密切监控脑波。

在法律和医学上做出关于死亡的定义所遇到的困境，也许反映了在整个生命过程中人们对于死亡在理解和态度上的改变。

生命历程中的死亡：原因和反应

学习目标**10.2** 分析个体在各个阶段死亡的原因及其对死亡的反应。

谢丽尔在学校的乐队是个长笛手，她有齐肩的棕色头发和棕色的眼睛。当朋友和兄长们讲一些有趣的事时，她经常偏着头咧嘴微笑。

谢丽尔的家有一个小型农场，她的任务是每天早上在校车到达之前喂完小鸡和收鸡蛋。在完成了琐碎的工作以后，酷爱设计和制作自己衣服的谢丽尔会整理她在家政课上缝制的东西，然后跟父母亲挥手告别。“小心，别受骗了啊！”她爸爸总是在后面这样喊着。谢丽尔觉得这真是个无厘头的笑话，她已经习惯了父亲这样的提醒。

一个星期五的晚上，谢丽尔的爸爸提议他们可以驾车去买点比萨来吃。谢丽尔觉得爸爸开车很安全，就没有系安全带。他们驶上一条双车道的高速公路，跟着广播里的音乐唱着歌。忽然，一辆迎面驶来的小车失去控制，越过中线撞上了他们的车。由于没有系安全带，谢丽尔被甩了出去。最终，她的爸爸和哥哥活了下来，而13岁的谢丽尔的生命在这里永远结束了。

我们通常会将死亡和“上了年纪”联系在一起，但对许多人来说，死亡可能来得很早。在这种情况下，死亡被视为是“非自然的”，就像谢丽尔一样，因此，“非自然死亡”引起的社会反应也尤为强烈。事实上，如今许多人都认为不应该让孩子们对死亡了解过多，以保护他们的感受。但各个年龄的人均有可能经历亲友或自身的死亡。因此，我们有必要知道人们对死亡的反应是如何随着年龄发展的。接下来我们将针对这一问题展开深入讨论。

婴幼儿期和儿童中期的死亡 虽然美国经济高度发达，但是新生儿的死亡率仍然很高。美国一岁以内新生儿的死亡率比许多国家都高（World Fact Book, 2016a）。

很多父母经历了失去新生儿的痛苦，这种影响对他们来说深远而巨大。失去孩子通常会引起个体和失去成人一样的反应，有时还会使家庭

成员遭受更严重的打击，最常见的后果就是极度抑郁，因为死亡发生得太早了（Murphy, Johnson, & Wu, 2003; Cacciatore, 2010）。

一种特别难以应付的死亡是产前死亡，又叫流产。在孩子出生前，父母通常已经和他们的孩子建立了某种心理上的联结，如果孩子在尚未出生时就已经死亡，父母就会觉得极度痛苦。更严重的是，亲朋好友通常很难理解流产带给父母们情绪上的打击，而这会加重父母对损失的主观体验（Wheeler & Austin, 2001; Nikčević & Nicolaides, 2014）。

另一种会引发极端压力的死亡是婴儿猝死综合征，它的冲击性主要在于它的发生太出乎预料了。

在婴儿猝死综合征的案例中，父母通常会感到极大的自责，熟人们也会怀疑死亡的“真实原因”。研究者至今没有发现引起婴儿猝死综合征的明确原因，它发生得近乎随机，因此，父母的内疚是并无根据的（Paterson et al., 2006; Kinney & Thach, 2009; Mitchell, 2009）。

对儿童来说，意外事故是导致其死亡的最重要因素，特别是车祸、火灾、溺水等。但是，美国有相当多的儿童死于谋杀，这一比例自1960年以来几乎翻了3倍。谋杀已经成为1~24岁孩子死亡的第四大原因，以及15~24岁非裔美国人的首要死因（National Vital Statistics Report, 2016）。

对父母而言，孩子的死亡将引发极大的丧失感和悲痛情绪。在多数父母眼中，没有什么会比孩子的死亡更让人难以接受了，这种痛苦甚至超过了丧偶以及失去父母所带来的悲痛。父母的极端反应部分源于现实违背了“孩子应比父母活得更长久”这一自然规律，同时也是因为他们觉得自己有保护孩子脱离任何伤害的责任，一旦孩子死亡，他们就会觉得是自己的失职（Granek et al., 2015）。

这种情况下，父母通常都没有做好应对孩子死亡的准备，因此他们可能会在事后反复责问自己造成这件事的原因。正因为父母与子女之间

的情感联结是如此之强，他们才会感到有时自己的一部分也随着子女的离去而死亡了。研究表明，这种压力会显著地增加父母患精神疾病而最终住院的风险（Nikkola, Kaunonen, & Aho, 2013; Fox, Cacciatore, & Lacasse, 2014）。

儿童的死亡概念 孩子本身在5岁以前尚未发展出有关死亡的概念，尽管他们在这之前可能已经意识到了死亡的存在，但他们更倾向于认为那只是一种暂时的、生命有所缩减但并未停止的状态。一个学前儿童可能会说：“死人不会感觉到饿，有的话可能也是一点点。”（Kastenbaum, 1985, p.629）。

有一些学前儿童会觉得死亡就和睡觉一样，如同童话中的睡美人，死人早晚会醒过来（Lonetto, 1980）。对有这种信念的孩子来说，死亡毫不可怕，而且还让他们觉得好奇。在他们的信念里，如果人们足够努力，比如通过施加有效的药物、提供充足的食物或者运用魔法，那么死去的人就可以“活过来”。

儿童对于死亡的错误理解会在其情绪上引发灾难性的后果。孩子们也许会认为他们该在某种程度上为某人的死亡负责，他们可能会认为如果自己做得更好些，死亡就可以避免；也可能会认为如果已经去世的人真的想要活过来的话，他们还是能够复生的。

从教育工作者的视角看问题

从个体发展阶段和对死亡的认识上，你认为学前儿童会对父母的死亡做何反应？

在5岁左右，儿童已经能够较好地理解生命的终结及其不可逆性，他们可能会给死亡赋予某种魔鬼或恶魔的形象。起初，他们认为死亡并非普遍存在，而是仅仅发生在特定的少数人身上；直到9岁，儿童会开

始承认死亡的普遍性和终结性（Nagy, 1948）；在儿童中期，儿童也习得了有关死亡的一些习俗，比如葬礼、火化、公墓等（Hunter & Smith 2008; Corr, 2010b）。

青少年期的死亡 我们可以想象，青少年期个体认知能力的飞速发展将会使他们对死亡的理解更加复杂、深入而合理，但在很多时候，青少年的观点依然会有和儿童一样不切实际的地方，尽管二者在理解深度上会有差异。

当青少年理解了生命终结和死亡的不可逆性的时候，他们倾向于认为死亡这件事不会发生在他们身上，然而持有这种观点可能会引发青少年的某些危险行为。正如我们在前文讨论的那样，青少年会发展出一种个人神话，即一系列使他们觉得自己很独特的信念。他们会认为自己是无法被侵犯的，那些发生在别人身上的糟糕事情并不会在自己身上发生（Elkind, 1985）。

这种危险行为导致了很多青少年的死亡。比如，在这个年纪，个体死亡案例中最普遍的原因是意外事故，通常由机动车等交通工具引起，其他常见的原因还包括谋杀、自杀、癌症和艾滋病等（National Vital Statistics Report, 2016）。

当青少年的个人神话不得不面对疾病引起的死亡时，这些事件给他们带来的影响常常是毁灭性的。得知自己面临死亡的青少年通常会觉得气愤和受到欺骗，觉得命运对他们非常不公。由于他们的感受和行为都如此消极，医护人员的救助往往很难奏效。

相反，一些被诊断为有绝症的青少年往往会表现出彻底的拒绝接受。那种坚不可摧的自我信念使他们无法接受自己所患疾病的严重性。不过在不影响他们接受治疗的情况下，一定限度的拒绝还是有一些好处的，因为它能使青少年最大限度地保持正常的生活状态（Beale, Baile, & Aaron, 2005; Barrera et al., 2013）。

成年早期的死亡 成年早期被看作是个体为生活做好准备的开始。经过了儿童中期和青少年期的准备阶段，个体开始在世界上留下自己独立的足迹。在这样一个时期，死亡几乎是不可想象的，因此它的发生也就格外让人难以接受。年轻人正积极地为完成生活目标而努力着，这时任何阻碍他们发展的疾病都会让他们感到气愤和不耐烦。



青少年对死亡的理解可能是非常浪漫且戏剧化的。

在成年早期，意外事故仍然是个体死亡的最主要原因，其次是谋杀、自杀和癌症。然而，在成年早期临近结束的时候，个体因患疾病而死亡会变得更为普遍。

对面临死亡的年轻人来说，有几个问题非常重要。问题之一是他们的发展亲密关系和表达性欲的渴望，而绝症会抑制甚至完全中断这两方

面的活动。例如，艾滋病毒检验结果呈阳性的人会觉得很难再开始一段崭新的关系，而已有关系中的性活动则面临更大的风险挑战。

问题之二是面临死亡的年轻人的人生规划问题。当大多数人开始为将来的职业和家庭绘制蓝图的时候，身患绝症的年轻人却要承受更多的负担。他们应该结婚吗，即使伴侣可能很快就将“落单”？这对夫妇应该有孩子吗，即使孩子可能只由父母中的一方养大？他们应该在什么时候将自己的病情告诉老板，即使这显然会对他们的工作不利？这些问题都很难找到答案。

成年中期的死亡 对成年中期的人们来说，患上可能威胁生命的疾病是这一年龄段中最普遍的死亡原因，但并不会给患者带来很严重的打击。因为到了这一阶段，人们都很清楚自己终有一死了，他们已经能够从一种更加现实的角度来看待死亡。

尽管如此，对现实的清醒认识也不能使成年中期的个体更易于接受死亡，他们对死亡的恐惧往往是一生中所有年龄段的人中最强烈的。这种恐惧可能使人们更在乎自己还有多少年可活，而不是关注自己已经活了多久（Akhtar, 2010）。

在成年中期，个体最普遍的死亡原因是心脏病和中风。尽管这些疾病的突发性常常使人难以准备，但这些疾病相比癌症之类的慢性疾病，前者给人们带来的痛苦要比后者带来的痛苦轻得多。这或许是许多人更为倾向的死亡方式，因为有研究发现，当被问到死亡方式的时候，大多数人会选择经历一个短暂而无痛苦的死亡，而且不会损失身体的任何部位（Taylor, 2014）。

成年晚期的死亡 到了成年晚期，人们已经知道自己的生命正在走向终点。除此之外，他们还面临着周围环境中越来越多的死亡，配偶、兄弟姐妹、朋友都有可能率先离开这个世界，这些都在不断提醒他们死亡的必然性。

在这个年龄段，个体最可能的致死原因是癌症、中风和心脏病。根据人口统计学家的估算，如果控制了这些因素，平均年龄70岁的老人们还有望再活7年左右。（Hayward, Crimmins, & Saito, 1997）。

由于死亡在老龄人群中普遍存在，因此和其他年龄段相比，这一年龄段的人群对死亡的焦虑相对较少。但这并不意味着成年晚期的人们更欢迎死亡，只能说他们看待死亡的态度更加实际。他们开始对死亡进行深入思考，并为其做准备。随着心理和生理机能的逐渐减弱，一些人开始远离社会事务了（Akhtar, 2010）。

死亡的临近常常伴随着认知功能的迅速衰退。在所谓的最终衰竭（terminal decline）过程中，成年晚期个体记忆和阅读能力的显著衰退，预示着在其后几年里即将到来的死亡（Thorvaldsson et al., 2008; Hülür et al., 2013; Gertsorf et al., 2016）。

一些老年人会选择自杀。实际上，男性的自杀率在成年晚期正持续攀升，85岁以上白人男性的自杀比例比任何一个年龄组都高。相比之下，青少年和成年早期自杀的总人数较多，但在整体人数中所占的比例却相对较低。自杀通常是重度抑郁或某种形式的痴呆导致的后果，也可能是丧偶所引起的（Mezuk et al., 2008; Kjølseth, Ekeberg, & Steihaug, 2010; Dombrowski et al., 2012）。

对身患绝症的老年人来说，一个关键的问题是他们活着是否还有价值。面临死亡的老年人比年轻人更担心自己会成为家庭和社会的负担。他们有时甚至会有意或无意地感知到这样的信息：社会不再认为他们是“重病”状态，而认为他们是“垂死”状态（Kastenbaum, 2000）。

在多数情况下，老年人都希望得知自己是否“死期将近”。如同年轻的患者常常愿意知道自己病情的真相一样，老年人也希望知道更多的细节。但具有讽刺意味的是，看护者常常回避告诉临终患者他们已无可救药（Goold, Williams, & Arnold, 2000; Hagerty et al., 2004）。

然而，并非所有的老人都愿意知道他们真正的病情或者他们即将死亡的消息。不同的人对待死亡的态度非常不同，个人因素尤其重要，比如，容易焦虑的人们更加担心死亡。此外，个体对待死亡的态度也存在显著的文化差异（见“文化维度”专栏）。

文化维度 不同的死亡概念

在一个部落的庆典中，一位老人正等待他的长子将一根绳子套在他的脖子上。老人身患重病，已经准备好离开人世，儿子遵从了父亲的要求——帮助他结束生命。



正如印度的这个仪式所显示的，人们对死亡的不同理解造就了不同形式的葬礼。

对印度教徒来说，死亡并不是终点，而是连续轮回的一部分，因为他们相信投胎转世，认为死亡是由重生接替的一个全新生命的开始。因此，死亡也被他们看作是生命的伴生物。

在不同的文化里，人们对死亡的反应表现为很多种形式，不过即使是在同一文化里，人们对死亡的反应也多种多样。例如，是选择做一个家庭事业有成、圆满过完一生的人好，还是做一个在国家的保卫战争中英勇牺牲的年轻战士更好？

答案由个人的价值观而定，这又与文化和亚文化的导向作用紧密相关，常通过宗教来传播。有些社会将死亡看成是一种惩罚，或是个人对世界的贡献；有些社会则把死亡看作从现实劳苦中获得解脱的一种方式；还有些社会把死亡看成是永生的开始；另一些社会中的人则不相信天堂的存在，认为生命只是如同现实中表现的那样而已（Bryant, 2003）。

美国印第安人将死亡看作是生命的延续。拉科塔（Lakota）印第安部落的人相信人们死后会到达一个叫作瓦纳吉·马科切（Wanagi Makoce）的精神家园，所有的人和动物都居住在

那里。因此死亡也就不会让他们感到愤怒或者不公平。同样，在诸如佛教和印度教等某些宗教中，人们信仰转生，相信灵魂会回到一个新的肉体中继续开始一个新的生命周期（Huang, 2004）。

人们了解死亡的年龄因文化而异。在暴力和死亡色彩较重的文化中，个体会更早地认识死亡。研究表明，北爱尔兰和以色列的儿童会比美国和英国的儿童更早地认识到死亡的终结性、不可逆性和不可避免性（Atchley, 2000; Braun, Pietsch, & Blanchette, 2000）。

死亡教育：为不可避免的终结做准备

学习目标**10.3** 描述死亡教育的目标和益处。

“妈妈什么时候能活过来？”

“为什么巴里会死？”

“祖父是因为我不够好才死的吗？”

儿童的这类疑问说明了为什么许多发展心理学家以及死亡学家（**thanatologists**）建议将死亡教育列入学校的日常教学内容，近年来这种课程已经出现了。“死亡教育”作为较新的一门课程应运而生，它主要是为帮助各个年龄段的人们更好地面对死亡和临终状况而设立的，其中包括面对自己和他人的死亡。

死亡教育的兴起往往源于人们过往对死亡话题的隐藏。因为担心儿童会受到惊扰，人们通常把与濒死患者打交道的任务交给医院，不和儿童谈论有关死亡的话题，也不让他们参加葬礼。即使是急救工作者和医疗专家也不能自如地和儿童讨论这个话题。由于成年人在日常生活中经常回避这一话题，儿童很少有机会面对自己关于死亡的感觉或获得有关死亡的更真实的感知（Wass, 2004; Kim & Lee, 2009; Waldrop & Kirkendall, 2009; Kellehear, 2015）。

以下是死亡教育课程的一些内容：

- 危机干预教育。纽约世贸大楼被袭击后，相关组织为了减轻儿

童的焦虑，将他们列为主要的危机干预对象。年幼儿童关于死亡的概念最不稳定，因此他们需要得到有针对性的、适合他们认知发展阶段的关于生命消殒的合理解释。在不那么极端的情形下，危机干预教育也同样能被应用，比如，当遇到学生被杀或自杀的案件时，学校一般都会开展应急咨询服务（Sandoval, Scott, & Padilla, 2009; Markell, 2010）。

- 常规死亡教育。在小学阶段，学校很少有关于死亡的教材，但在高中阶段，常规死亡教育已经相当普遍了。在大学里，诸如心理学、人类发展学、社会学、教育学等院系也逐渐开设了这类课程（Eckerd, 2009; Bonoti, Leondari, & Mastora, 2013; Corr, 2015）。
- 对助人职业人员的死亡教育。死亡、临终关怀和丧葬等相关职业的专业人员特别需要这方面的死亡教育。现在，几乎所有的医疗和护士学校都会为学生提供某种形式的死亡教育。而最成功的教育不仅要教会学生如何帮助患者及其家属妥善处理好即将到来的死亡，还要进一步引导学生对该话题本身进行思考（Haas-Thompson, Alston, & Holbet, 2008; Kehl & McCarty, 2012）。

尽管没有任何一种死亡教育能够完全把死亡解释清楚，但以上这些课程却可以帮助人们更加理解死亡这个普遍而必然的生命阶段。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标**10.1** 如何判定死亡。

功能性死亡被定义为心脏停止跳动和呼吸停止；脑死亡被定义为脑电波消失。死亡的定义随着医学发展而改变，这让拯救那些原本被认为

已经死亡的人成为可能。一些医学专家认为，当一个人丧失思考、推理、感觉和体验世界的能力，并且再也不可能重新恢复身为人的生命活动表征时，那就是死亡发生的时刻。

学习目标10.2 分析个体在各个阶段死亡的原因及其对死亡的反应。

婴幼儿的死亡对父母来说尤其难以接受，而对青少年来说，死亡几乎是不可想象的。在死亡的态度和信念上的明显文化差异强有力地影响着人们对死亡的反应。

学习目标10.3 描述死亡教育的目标和益处。

死亡学家建议将死亡教育列入正常的学习课程中去，以帮助人们理解这一普遍又必然的人类经历。

自我检测

1. 一旦某人不再有心跳或呼吸，那么他经历的是____。
 - a. 功能性死亡
 - b. 系统关闭
 - c. 脑死亡
 - d. 法律死亡
2. 在____，使个体感到自己不会被侵犯的个人神话，令发生在这一时期的死亡尤为意外和具有毁灭性。
 - a. 童年期
 - b. 青少年期
 - c. 成年早期

- d. 成年中期
3. 研究死亡和濒死过程的人叫作_____。
- a. 细胞学家
 - b. 死亡学家
 - c. 神经病理学家
 - d. 畸胎学家
4. 在学校内提供的、帮助学生们面对诸如2001年对世贸中心和五角大楼的袭击事件这样的突发事件的应急咨询叫作_____。
- a. 常规死亡教育
 - b. 死亡学培训
 - c. 危机干预教育
 - d. 启蒙培训

应用于毕生发展

你是否认为学校应当对儿童和青少年进行反对自杀的教育？在这个年龄阶段进行反对自杀的教育会带来什么不利因素吗？儿童是否最好早点接触这个话题？

10.2 面对死亡

决定和世界说再见

卡萝尔·雷耶斯是个闲不住的人。在89岁那年盆骨骨折后，她还是决定要重新开始走路。经过6个月的密集复健，她果真能独立行走了。

93岁时，卡萝尔得了肺炎，她在医院住了一个月之后就回了家，家里有她的猫和满屋藏书。她依然积极参与当地的政治生活——尽管比之前要虚弱一些，但她基本没什么问题。

3年后，医生告诉卡萝尔，她得了肌萎缩侧索硬化（amyotrophic lateral sclerosis, ALS），这是一种脑部和脊柱里的运动神经元慢慢死去的疾病。她可以服用一种叫利鲁唑片（Rilutek）的药来减缓这个过程，但她的肌肉最终还是会萎缩，并导致她无法再使用双手或双脚。她会出现说话和吞咽困难，肺也会最终失去机能。

卡萝尔同意尝试药物，但是她告诉医生，她想签下“不必进行施救”（Do Not Resuscitate, DNR）的预嘱，即如果她开始有呼吸困难，就请医生为她遵循“不必进行施救”的原则。“我不想那样活着。”她说。



4个月后，卡萝尔开始呼吸困难，她拒绝吸氧，也拒绝去医院。不久之后，她就在自己的床上离世了。卡萝尔的死引发了一系列的问题。她拒绝吸氧等于自杀吗？医护人员应该答应她的要求吗？她这样对待死亡是最有效的解决之道吗？人们应该如何面对并适应死亡？毕生发展心理学家与从事死亡和临终研究的专家正在努力寻找这些问题的答案。

在本节中，我们将探讨人们会如何面对自己的死亡。我们将讨论一种理论，该理论认为，当面对死亡时，人们都会经历一系列阶段。我们

还会探讨人们如何使用生存意愿遗嘱以及辅助自杀。

理解临终过程

伊丽莎白·库伯勒-罗斯（Elisabeth Kübler-Ross）的研究工作对我们理解人类如何面对死亡帮助巨大。作为一名精神病学家，库伯勒-罗斯根据对临终患者及其看护者的调查，发展出了一套关于死亡和濒死体验的理论（Kübler-Ross, 1969, 1982）。

一步一步迈向死亡：库伯勒-罗斯的理论^[32]

学习目标**10.4** 分析库伯勒-罗斯的临终过程理论。

库伯勒-罗斯最开始认为人们需要经过五个步骤以面对死亡（见图10-1）。

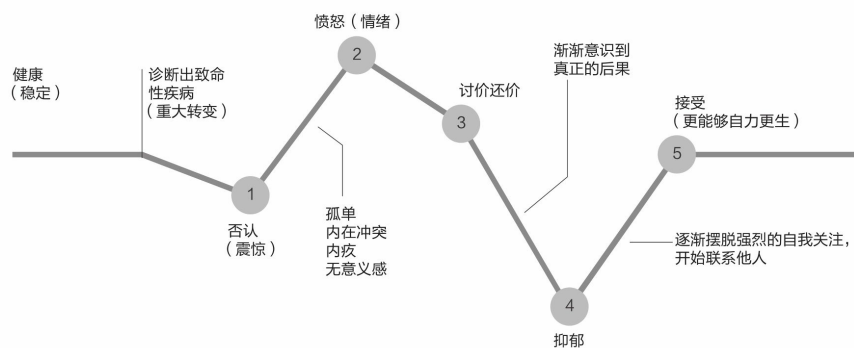


图10-1 走向生命的终结

根据库伯勒-罗斯1975年提出的理论，以上是个体走向死亡的不同步骤。你认为其中是否存在文化差异呢？

否认 “不！我不可能会死！肯定是哪里搞错了！”这是人们在获知自己临近死亡时最典型的反应，也是面对死亡的第一个步骤：否认。在否认的过程中，人们不肯承认自己即将死亡。他们可能反驳说诊断结果有误，X光检查结果被误读或者医生们弄错了。他们也可能会直截了当

地否认诊断结果。在极端案例中，患者会丢失自己在住院那几周的记忆。还有其他形式的否认，比如患者会在拒绝接受诊断结果和承认他们知道自己即将死亡之间反复摇摆（Teutsch, 2003）。

否认绝不是丧失现实感的标志，也不是精神健康状况恶化的迹象，它是一种帮助人们以自己的方式和步伐接纳不愉快信息的防御机制。只有这样，患者才能继续有勇气面对生活，直到接受自己即将死亡的事实。

愤怒 经过了“否认”阶段以后，人们可能表现出愤怒。他们可能会对每一个身体健康的人、配偶和其他家庭成员、看护者以及孩子发脾气。他们可能会猛烈地抨击他人，质问为什么偏偏是自己要死了。他们可能会抱怨世道不公，认为自己一生为善，而世界上还有许多坏人应该死去。

与处在“愤怒”阶段的人相处是个艰巨的任务，他们可能会有一些让人痛苦和难以理解的言行。尽管如此，他们中的大多数人最终都将渡过这一阶段并进入下一阶段：讨价还价。

讨价还价 “好人有好报”，许多人会将这种童年阶段习得的说法应用到自己即将面对的死亡中。他们承诺如果自己能够继续活下去，就一定成为一个更好的人。

在讨价还价的过程中，垂死的人总是试图通过谈判来摆脱死亡。他们可能会宣称，如果这次能被拯救，他们就将献身于穷苦人民。他们还可能承诺，如果可以活到亲眼见证儿子结婚，之后就会心甘情愿地接受死亡。

但是，他们许下的承诺很少能兑现。如果其中一个要求得到满足，人们通常又会去寻找下一个，然后再一个。此外，他们可能根本无法履行自己的承诺，因为随着病情逐渐加重，他们已经无法实现之前想要做的事情了。

在某些方面，讨价还价也会带来一些正面的结果。尽管死亡不能被绝对推迟，但是以参加某一特定活动或活到某一特定时间为目标可以延迟死亡的到来。例如，犹太人的死亡率在逾越节前会显著降低，而在过节之后又有所回升。与之类似，中国老年妇女在重要节日之前和节日期间的死亡率也会显著降低，而在节日后又有所回升（Phillips, 1992）。

当然，没有人能通过讨价还价最终逃离死亡。当人们终于意识到这一点时，便进入了“抑郁”阶段。

抑郁 许多临死的人都经历过抑郁阶段。当患者意识到死亡已成定局，他们无法以任何讨价还价的方式逃脱的时候，人们就会产生一种巨大的失落感。他们知道自己的生命真的正在走向终结，并且自己就要失去所爱的人了。

他们的抑郁可能是反应型或预备型的。在反应型抑郁（reactive depression）中，人们的悲哀建立在过去已经发生过的事件上：接受各种治疗所带来的尊严丧失、不能再工作或是得知永远无法重返家中等。在预备型抑郁（preparatory depression）中，人们的悲哀建立在即将到来的损失上：他们知道死亡会使自己的社会关系终结，他们将永远无法见到自己的后代。死亡的现实在这一阶段已无法逃脱，这将引发患者巨大的悲痛。

接受 库伯勒-罗斯认为死亡的最终阶段是接受。到达接受阶段的人们会充分认识到死亡的迫近。伴随着情感淡漠和少言寡语等一系列表现，他们对现在和将来已经没有任何积极或消极的感觉。他们和自己讲和，想要独处。对他们而言，死亡不再引发痛苦。

从教育工作者的视角看问题

你认为库伯勒-罗斯的死亡五阶段理论是否受到文化的影响？是否存在年龄差异？为什么？

评价库伯勒-罗斯的理论 库伯勒-罗斯对我们有关死亡的看法产生了巨大的影响。她被看作是采用系统观察方法研究人们如何面对死亡的先驱。她几乎单枪匹马地把死亡现象带入了公众的视野。她的理论对那些直接照顾濒死者的人有更大的作用。

另外，库伯勒-罗斯的研究成果也受到了一些批评。她关于死亡概念的定义有明显的局限性，其定义只局限在那些已经获知自己即将死亡或是那些死亡时限较长的人。对那些罹患难测疾病，并不知道结局和最后时限的人而言，她的理论就不太适用。

反对者对库伯勒-罗斯理论激烈的批评在于其理论中“阶段论”的本质。他们认为并非每个迈向死亡的人都会经历这五个阶段的每一步，也有些人会以其他的顺序经历这些阶段，甚至有些人会在同一阶段上重复经历好几次。抑郁的患者可能会表现出暴怒，愤怒的患者也可能会更多地讨价还价（Gilbert, 2012; Larson, 2014; Corr, 2015）。

不是每个人都会以同样的方式经历这些阶段。比如，有一项针对200多名最近刚刚丧失亲人的被试的研究，研究者在被试丧失亲人时立即对其访谈一次，然后在几个月之后再访谈一次。如果库伯勒-罗斯的理论是正确的，那么最终的接受阶段将在一段较长的悲伤之后到来。然而多数被试在一开始就表现出了对他们所爱之人过世这一事实的接受。而且，被试没有像理论假定的那样经历愤怒或抑郁这两个哀悼的阶段，他们更多的是报告自己感到了对亡者的强烈思念。哀悼的过程不太像是一系列固定的阶段，而更像是一个症状此起彼伏地出现，直到最终消散的历程（Maciejewski et al., 2007; Genevro & Miller, 2010; Gamino & Ritter, 2012）。

研究发现，人们在哀悼的过程中通常会遵循自己独特的个人轨迹，这一发现对医疗工作者和其他与临终之人一起工作的护理人员都非常重要。因为库伯勒-罗斯的死亡阶段划分已经广为人知，好心的看护者有时就会激励患者按照已知顺序经历这些阶段，却忽略了患者的个体需

求。

最后需要指出的是，在面对即将到来的死亡时，人们的表现存在巨大差异。死亡的确切原因，死亡过程会延续多久，患者的年龄、性别和人格特征，以及能从家人和朋友那里得到的社会支持程度等都会影响整个死亡进程和人们对死亡的反应（Carver & Scheier, 2002; Roos, 2013）。

针对库伯勒-罗斯理论的局限性，一些研究者也提出了其他观点。比如心理学家埃德温·施耐德曼（Edwin Shneidman）认为，人们在面对死亡的过程中，可能以任意顺序产生或反复产生一些相关的反应“主题”。这些主题包括怀疑的想法、不公平感，对剧痛甚至是一般疼痛的恐惧，以及有关痊愈的幻想（Leenaars & Shneidman, 1999; Shneidman, 2007）。

另一位研究者查尔斯·库尔（Charles Corr）认为，就像在人生其他阶段一样，面对死亡的人也面临着一组心理任务，包括尽可能减少生理不适、维持生命的丰富感、继续或深化与他人的关系，以及保持希望（Corr, Nabe, & Corr, 2006, 2010; Corr, 2015）。

选择死亡的本质

学习目标**10.5** 解释人们学着掌控自己最后一段岁月的方法。

在科林·拉帕森德成为住院医师的第一年，他的第一个岗位是在老年病房。科林总是高兴而亲切地称每个患者为“大叔”或者“阿姨”。

他对其中一位患者印象尤为深刻。“经过一天繁忙的工作后，我总喜欢和杰茜卡阿姨一起打发时间。她是一个93岁的老人，住院不久就卧床不起了，但头脑依然敏捷。我有时值夜班时会坐到她的床脚和她聊天。她是个有很多故事、有伟大思想和鲜活智慧的人。”

“杰茜卡阿姨的病历上注明她是一个签过‘不必进行施救’预嘱的患者，我知道她不想再接受任何‘徒劳无益的医疗’。然而，有天夜里我独自值班，就顺便来到杰茜卡阿姨的病房探望她，发现她的呼吸指数跌到了零并且心跳时断时续。看着她的体征指数状况越来越糟，我没有站在那里‘顺其自然’，而是走到她身边喊她的名字，同时快速地按压她的胸部，每分钟100次，对她施行心肺复苏术。我努力让她的呼吸回到正常水平，但她的心跳仍然很微弱。

“我抓起电击器给了她电击，很幸运，在第三次的时候我成功了，她的心跳再次出现，并且渐渐恢复到了平常水平。在这件事之后，杰茜卡阿姨又活了4个月。

“我对主管说，我当时忘记了那是一个签过‘不必进行施救’预嘱的患者，但其实我没忘。我也只是‘顺其自然’而已，在这里，自然就是我的天性，作为人类的天性。”

“不必进行施救” 患者病历上的“DNR”有一个简单明确的含义：“不必进行施救”。“不必进行施救”强调不必采取任何手段维持患者的生命。对身患绝症的患者来说，“不必进行施救”可能意味着立刻死亡，非“不必进行施救”患者或许能够多活几天、几个月甚至几年，但往往需要许多极端的、侵入性的甚至是非常痛苦的医疗措施来维持。



许多绝症患者选择“不必进行施救”作为一种回避极端医疗干预的手段。

“不必进行施救”的存在是否合理引起了一些讨论。一个争论是“极端”措施和常规措施究竟有何不同。事实上，这两者之间并不存在严格的区别。做决定的人必须考虑患者的需求、医疗史、年龄、宗教等因素。比如，医生对同一病情下12岁和85岁的患者可能需要采取不同的标准。另一个争论和生活质量有关，我们该如何衡量患者的生活质量，并决定是否采用特殊的医疗手段辅助其继续活下去呢？谁来做这样的决定，患者、家属还是医生？

不过有一件事很明确，就像前文提到的医生科林那样，医疗工作者有时并不会按照绝症患者及其家人的意愿中断侵入性治疗。即使在患者肯定会走向死亡、患者本身也不愿意接受治疗的情况下，医生通常也会宣称不知道患者的这些愿望。尽管有1/3的患者要求不再接受治疗，这其中却只有不到一半的医生承认他们知道患者的这种意向，另外，只有49%的患者病历上留有生存意愿记录。医护工作者可能不愿意按照患者的“不必进行施救”要求去做，一部分原因是他们过往接受的训练要求他们去拯救患者，而不是任其死亡，另一部分原因是医护工作者担心自己

不施救会引起法律责任（Goold, Williams, & Arnold, 2000; McArdle, 2002; Goldman et al., 2013）。

生存意愿遗嘱 为了对死亡拥有更多的控制权，越来越多的患者会选择签署生存意愿遗嘱。生存意愿遗嘱（**living wills**）是指当事人事先指定是否接受医疗救护措施，以便在当事人无法表达意愿的情况下履行其意志的法律文件（见图10-2）。

我，_____，

如果因疾病而永久不能对后续治疗做出决定时，请让这份文件作为我清醒时的意愿表达。它反映的是在遭遇如下情形时，我不愿使用任何药物治疗的坚定决心：

当我的病情已经无可救药，心理和生理上都没有康复的可能，医院对我的治疗仅仅只是延续生命时，我要求主治医生停止对我治疗。这一条款适用于但不限于以下情形：(a) 临终情形；(b) 永远不能恢复意识的状况；(c) 有微弱意识但我永远无法做出决策或表达愿望的状况。

我要求医生对我的治疗仅限于让我舒服或是减轻我的痛苦，包括在取消治疗后产生的任何痛苦。

虽然知道不能从法律意义上对未来的治疗做出详细的要求，但我仍然强烈希望在遇到上述情形时，医生能对我采取如下措施：

不使用心肺复苏术；

不使用呼吸机；

不使用饲管；

不使用抗生素。

我确实想要最大限度地减轻疼痛，哪怕所采取的措施有可能会减少我的寿命也在所不惜。

其他个人要求：

这些要求表达了在法律框架下我行使拒绝治疗的权利。我希望这些能够实现，除非我废除了这份声明并重新写了一份，或者是有明显的证据表明我改变了主意。

签字_____日期_____

地址_____

证人声明

我声明该文件的签署者在签署时年龄超过了 18 岁，没有受到强迫或其他过分的影响，充分表达了他的意愿。在签署人签署或委托他人代自己签署时我在场。

证人_____

地址_____

证人_____

地址_____

图10-2 生存意愿遗嘱范例

为确保生存意愿遗嘱中的愿望能被实现，人们需要采取哪些步骤？

有些人会指定一位特殊人员（如医疗代理人）代表患者参与制定医疗救护的相关决策。医疗代理人被授权处理患者的生存意愿和在被称为长期授权书（durable power of attorney）的法律文件中规定的事宜，内容可能涉及诸如昏迷在内的所有医疗问题，也可能仅仅涉及绝症。

和“不必进行施救”的命令一样，如果患者没有同时明确地向医生和自己的医疗代理人表达意愿的话，生存意愿遗嘱里的内容将不被执行。为了使患者的意愿得以顺利施行，人们还应当事先和自己的医疗代理人进行坦诚的交谈，表明自己的愿望。

安乐死与辅助自杀 在20世纪90年代，杰克·凯沃尔基安（Jack Kevorkian）医生因发明并推广了“自杀机器”而广为人知。只要患者按一下按钮，这种机器就会释放麻醉剂和一种可以使心脏停止跳动的药物。由于帮助患者通过自主操作这种机器摄入药物，凯沃尔基安事实上参与了“辅助自杀”的过程，为濒死患者提供了自杀途径。因为在电视节目《60分钟》中参与了对患者的辅助自杀，凯沃尔基安被指控二级谋杀罪，要在监狱里度过8个年头。

辅助自杀在美国引起了巨大争议，而且在许多州都是违法的，但在俄勒冈州却是个例外，那里在1998年通过了《死亡权利法》。法律的实施并没有造成辅助自杀的泛滥，在最初的12年里，只有不到300人使用了药物来终结他们的生命（Ganzini, Beer, & Brouns, 2006; Davey, 2007; Edwards, 2015）。

在很多国家，辅助自杀已被广泛接受。比如在荷兰，医疗人员可以帮助患者结束生命。但是，辅助自杀必须符合以下三个条件：至少两名医生将患者的病情诊断为不治之症，患者存在无法忍受的物理或精神创伤，患者须给出书面同意书并事先告知患者家属（Battin et al., 2007; Onwuteaka-Philipsen et al., 2010; Augestad et al., 2013）。

辅助自杀是安乐死（**euthanasia**）的一种形式，安乐死是指帮助濒死患者更快死亡的措施。安乐死通常被视为“善意谋杀”，存在多种形

式。被动安乐死（passive euthanasia）包括移除呼吸机或去除其他有助于维持生命的医疗仪器，以此帮助患者自然死亡，比如医护人员遵行“不必进行施救”命令。在主动自愿安乐死（voluntary active euthanasia）中，看护者或医务人员将在患者自然死亡之前采取相应行动，也许会使用某种致命的药物或过量用药等。正如我们所看到的，辅助自杀介于被动和主动自愿安乐死之间。尽管安乐死饱受争议，但是其使用范围却惊人地广泛。一项对特别看护病房护士的调查结果表明，20%的护士曾经至少一次故意加速了患者的死亡进程，而且其他专家也指出，安乐死并不罕见（Asch, 1996）。

关于安乐死的争论源于究竟谁应该控制患者的生命这一问题。这种权利只属于个人，还是属于医生、家属、政府或自然的力量？因为我们相信每个人都有把孩子带到这个世界上的绝对权利，所以有些人宣称我们同样也具有结束自己生命的绝对权利（Allen et al., 2006; Goldney, 2012）。

很多反对者认为安乐死无法在道德上被接受。在他们看来，不论患者本身的意愿如何，提前结束一个人的生命都与谋杀无异。另一些人指出，医生对患者未来寿命的预测通常不够准确，比如，一项大规模的关于理解治疗风险和预后⁽³³⁾结果的研究发现，患者的实际寿命通常超过了医生对他们的预期寿命。在某些情况下，被诊断为有50%的可能活不过半年的患者，最终还可以再活好多年（Bishop, 2006; Peel & Harding, 2015）。

反对安乐死的另一个观点基于患者的情绪状态。在患者请求安乐死的时候，他们可能正陷入某种形式的极度抑郁之中，而一旦服用抗抑郁药物使其抑郁症状减轻后，患者可能会改变先前放弃生命的愿望（Gostin, 2006; McLachlan, 2008; Schildmann & Schildmann, 2013）。

死亡的地点：临终关怀

学习目标10.6 描述为患者提供临终关怀的方式。

迪娜是密歇根医院的一名护士，她的工作是照顾绝症患者并尽量满足他们生理和心理的需求，她热爱她的工作。

“你需要有同情心和良好的临床背景，”她说，“你也要有韧性，因为你可能会去患者家里、医院、私立诊所、成人看护所等任何患者所在的地方。”

迪娜喜欢这种跨学科的工作。“你需要和别人组成一个团队，他们包括社会工作者、精神关怀者、家庭健康支援者、对丧失亲人个体的支持者以及行政支持者等。”

令人惊讶的是，这项工作最具挑战性的地方并不在于和患者打交道，而在于如何面对其家属和朋友。

“患者家属往往正处于惊恐状态，好像所有的事情都失控了。并非所有人都做好了接受家人即将死亡的准备，所以你要特别注意你的措辞。如果事先妥善地告知他们将要发生的状况，那么接下来的事情就会更加顺畅，这也能给患者营造一个更加舒适的气氛。”

美国大约一半的患者会在医院迎来死亡。但通常情况下，患者都不愿意在医院结束生命。因为医院过于程式化且缺少温情，患者也会由于医院探视时间的限制而鲜少得到亲人的安慰和陪伴，只能孤独地死去。

医院只能提供治疗，却无法为临终患者提供特别看护；而且医院的临终看护价格也非常昂贵。因此，医院通常无法满足临终患者及其家属的情感需求。

正因如此，除了住院以外，临终患者还有一些其他选择。家庭看护（**home care**）是个不错的选择，濒死的患者可以在家接受上门医护人员的治疗。许多濒死的患者更喜欢家庭看护，因为这可以让他们在熟悉的环境中度过最后的日子，与他们所爱的人在一起，与一生积累的财富

在一起。

但是家庭看护对患者的家庭成员来说是个巨大的挑战。尽管临终看护给家庭成员带来了巨大的心理安慰，因为他们所爱之人能始终待在家人身边，但家庭成员需要24小时随时待命，这对家庭成员来说，无论在体力上还是精神上都是巨大的消耗。而且，由于多数患者的家属并未经过专业的看护训练，所以他们可能无法提供最佳照料（Perreault, Fothergill-Bourbonnais, & Fiset, 2004）。

另一种日益流行的替代住院治疗的方法是临终关怀。临终关怀（**hospice care**）是相关工作人员为医疗机构里身患绝症的濒死患者提供照料的一种看护方式。临终关怀的宗旨是为临终患者提供充足的社会支持和温暖的氛围，其工作重点并不在于延长人们的寿命，而是使患者最后的日子变得愉快且有意义。一般来说，接受临终关怀的人们将不再进行痛苦的治疗，也不会采用额外的侵入性的手段来延长他们的寿命。临终关怀强调的是使患者的生活过得尽可能充实丰富，而不是想尽一切办法地延长其生命（Johnson, Kassner, & Kutner, 2004; Hanson et al., 2010; York et al., 2012）。

尽管此项研究尚无定论，但接受临终关怀的患者对照料的满意度看起来确实比其他接受传统治疗的患者高。因此，可以说临终关怀为绝症患者提供了一种明确的替代传统入院治疗的方法。（Tang, Aaronson, & Forbes, 2004; Seymour et al., 2007; Rhodes et al., 2008; Clark, 2015）。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标**10.4** 分析库伯勒-罗斯的临终过程理论。

库伯勒-罗斯定义了临近死亡的五个阶段：否认、愤怒、讨价还价、抑郁、接受。尽管库伯勒-罗斯增进了我们对临终过程的理解，但

是她定义的这些步骤并非都会发生。最近一些其他的研究者给出了不同的看法。

学习目标10.5 解释人们学着掌控自己最后一段岁月的方法。

人们对临近死亡话题有非常多的争议，包括医生应采取何种程度的治疗来维持濒死患者的生命，以及该由谁来做出这些决定等。辅助自杀，或者更普遍的“安乐死”同样引起了很大争议。尽管许多人主张如果有规范的管理，安乐死应该被合法化，但在许多国家中，这种做法仍存在很大争议。

学习目标10.6 描述为患者提供临终关怀的方式。

尽管大部分美国人都在医院里迎来死亡，但越来越多的人选择在他们的生命中最后的日子接受家庭看护或临终关怀。

自我检测

1. 库伯勒-罗斯提出迈向死亡的人会经过几个基本阶段。第一个阶段是____。
 - a. 哀悼
 - b. 接受
 - c. 愤怒
 - d. 否认
2. 库伯勒-罗斯认为，在____阶段，临终者可能会祈求只要能再多给他们几个月的生命，他们就愿意把财产捐给慈善机构。
 - a. 愤怒
 - b. 抑郁

- c. 否认
 - d. 讨价还价
3. 在医疗界，DNR的含义是_____。
- a. “不要更新”（Do Not Renew）
 - b. “每日修订通知”（Daily Notice of Revision）
 - c. “不要苏醒”（Do Not Revive）
 - d. “不必进行施救”（Do Not Resuscitate）
4. 有些人被指定为代表患者行使医疗决定的人，这样的人叫作_____。
- a. 健康助理
 - b. 医疗代理人
 - c. 法律援助
 - d. 个人护理专员

应用于毕生发展

你认为建议一位处于绝症临终前讨价还价阶段的患者接受临终关怀服务是否明智？在患者处于库伯勒-罗斯理论中的哪个阶段时给出这种建议最为恰当？

10.3 悲痛及丧亲

面对空虚

“当他们告诉我我丈夫吉姆在手术中死去的时候，我一句话都说不出来。我当时只想找个小黑屋，缩成一团然后彻底睡过去。是不是有点

儿不可思议？因为我所想做的和一个垂死的人没什么两样。但那时言语和情感都可能刺痛我，我只能麻痹自己。我担心自己会垮掉。我在吉姆死去两天后回到家中，所见的一切都让我心痛——他的衣服、他的吉他和所有的照片。现在两个月过去了，我稍稍好些了，但是依然难过。”

以上是78岁的凯特的自白，她已经开始了寡居生活。

失去亲人是一种普遍的经历，但其实我们中的大多数人都缺乏必要的准备。特别是在预期寿命长、死亡率逐渐降低的社会里，人们倾向于将死亡看作是一个反常的现象，而非必然。这种态度使得失去亲人的悲痛更加令人难以忍受。

在这一节，我们将考虑丧亲和悲痛。我们会看到区分正常的悲痛和不健康的悲痛的困难，以及丧亲带来的后果。我们还会探讨丧葬礼仪，讨论人们如何为必将到来的死亡做好准备。

死亡对生者的影响

“在我们的文化中，只有婴儿死亡后会进行土葬，其他人死亡后都是要进行火化的。父亲去世的时候，我大哥在人群的注目下走向上面躺着父亲的柴堆，然后将其点燃。

“父亲的躯体立刻被烈焰包围。当柴火燃尽后，我哥哥负责骨灰和骨头碎片的收殓工作，我们则都去洗了个澡。尽管经过了洗澡等一系列步骤，但在13天内，我们这些人作为死者的近亲仍然被认为是不洁的。

“13天以后，我们饱餐了一顿。我们在餐桌中央放一粒花生米，以献给父亲的灵魂。吃完饭后，我们拿出礼物分给了周边的穷人。”

在印度文化中，这种仪式代表了人们对逝者的纪念。还有人认为这样能够帮助逝者的灵魂到达死神所在的地方，而不是成为在世间游荡的孤魂野鬼。

这种仪式是印度特有的，但它在对执行葬礼各环节的人选的谨慎规定和着重表达对死者的尊重上，和其他社会的丧葬有许多共同之处。对绝大多数人来说，葬礼是表达悲痛的第一步。

送别：最终的仪式

学习目标**10.7** 分析葬礼在不同文化中的文化意义。

在美国，丧葬的花销可不小。平均的丧葬仪式费用高达7 000美金，包括一口华丽的棺材，用豪华轿车将死者运送到公墓，遗体保存以及遗体告别等费用（Bryant, 2003; AARP, 2004）。

葬礼之所以宏大，一定程度上是源于负责葬礼者的情感需求。他们通常是死者的近亲，希望证明自己对死者的爱，因此很容易被说服应当为死者选择“最好的”葬礼（Culver, 2003）。

但从文化角度讲，葬礼的形式和婚礼一样，都是由风俗习惯决定的。一场葬礼不仅仅是向公众宣布某个人的死去，也是对死亡必然性的认同和对生命循环不息的接受。



每个社会都有自己的对亡者的哀悼方式。



一个人的死亡对爱他的人甚至整个社会来说都代表着一种重要的转变，因此与死亡有关的仪式就显得尤为重要。死亡带给人们情绪上的巨大震撼，再加上商家的游说，常常导致人们对葬礼过度花费。

在许多文化下，丧葬仪式都有自己传统的规范模式。在葬礼之前，人们会给遗体穿好特定的衣裳，再以某种方式将其保存好。葬礼通常包括宗教仪式典礼、致辞、某种形式的队列以及其他一些规范程序，比如

天主教徒的“守灵”（wake）以及犹太教徒的七日“服丧”（shivah），此时亲戚朋友都会去拜会丧亲的家庭，并对死者表达敬意。

不同国家的葬礼有所不同。在一些社会里，送葬者会以剃头表示悲痛，而在另一些地方，人们则会为了纪念死者而任凭头发生长。还有一些文化中，哀悼者甚至可能是被雇来哭丧的。有些文化的葬礼上会出现一些喧闹的仪式，而另一些文化下大家则习惯在葬礼上保持肃静的氛围。文化甚至决定了葬礼上的情绪表达，比如哭泣的次数和时间等（Peters, 2010; Hoy, 2013）。

在印度尼西亚巴厘岛上的葬礼中，哀悼者们往往会表现得很平静，因为他们相信只有在自己很平静的时候，上帝才能听得见祷告。与之相对的是，在非裔美国人的葬礼上，哀悼者要表现出他们的悲痛，葬礼允许参与者表现出他们的感受（Rosenblatt & Wallace, 2005; Collins & Doolittle, 2006; Walter, 2012）。

在历史上，一些文化里曾经出现过相当极端的丧葬仪式。比如殉夫（suttee），这是一种传统的印度殉葬仪式，现在已经被法律禁止。在这种仪式中，寡妇要主动跳入燃烧丈夫尸体的烈火中，这些烈火被看作是其丈夫身体的一部分。

最后，无论不同文化下的丧葬仪式有多大差异，葬礼都有一个共通的功能，即作为某位死者生命终结的标志，也为生者提供一个正式的机会，让他们聚在一起，分担悲伤并互相安慰。

丧亲与悲痛

学习目标10.8 描述生者对死亡的反应和应对方式。

悲伤的消息像巨浪一样席卷了全世界：美国传奇歌手“王子”（Prince）逝世了，享年57岁。作为一位唱片销量以亿计、世界巡演票房收入数十亿美元的流行明星，“王子”可以说是英年早逝。

“王子”的逝世引发了全球性的悲痛。纪念活动在许多国家展开，政要和名流纷纷献上悼念的礼物。很多地方都举行了音乐悼念仪式，他的唱片销量再创新高。

从研究到实践 火葬的兴盛

当你死后，你的身体将会被如何处理？直到大约20年前，大部分人对这一问题的回答都是一样的：会被土葬。土葬是将遗体放在木质或金属的容器中，然后埋进地里。进行土葬的遗体通常会被安置在一片墓地中，且人们会用石质或是金属的纪念物对其位置加以标记。在人们逝世之后，遗体首先会被注射防腐剂来减缓其分解速度，使之能够保存足够的时间，让参加葬礼的人完成吊唁和葬礼，但最终依然没有什么能够阻止遗体的分解（Sanburn, 2013）。

火葬利用集中的热量和火焰大幅加速遗体的分解，在约一个小时内就能实现其在地下多年才能完成的过程。由此，遗体被压缩成灰、矿物质和骨头碎片混合的小堆，较大的骨头碎片会再次被粉碎。在美国的历史上，很大程度上因为囿于传统和宗教的制约，火葬一直不如土葬受欢迎。但在20年间，火葬开始渐渐流行开来：美国的火葬率已经从20世纪90年代末的不足25%上升到2012年的近50%，据预计，这一比值在接下来的几十年中还会继续增长（Defort, 2012）。

为什么人们的偏好突然从土葬转向火葬了呢？这主要源于人们出自经济方面的考虑。2008年经济衰退之后，美国人开始趋于节俭，而火葬的成本远远低于土葬，大约只占后者的1/3。但其他因素也同样起到了作用，比如日益增加的人口迁移。在大多数人生老病死都在同一片土地上的时代，土葬富有更多的意义。而当人们越来越多地离开故乡外出求学、工作、退休，并最终在另一处不同的土地上逝去时，人们甚至都不知道该如何选定土葬的地点（Dickinson, 2012; Sanburn, 2013）。

火葬不仅成了土葬的替代选择，也为人们提供了新的富有创造性和个人化的方式来纪念逝者的一生。火化后的遗骸可以存放于各种美丽的容器中，做成珠宝，也可以用于栽培树苗，或是播撒在某些有特殊意义的地方，甚至还可以变成珊瑚礁，或被发射到太空中。但火葬也有一个很大的缺点，即没有一个长存的纪念碑。由于没有特定的埋葬地点，逝者的后代也无处探访他们祖先的安息之地（Roberts, 2010）。

当你逝世之后，你是更愿意选择土葬还是火葬？为什么？

在深爱的人死去后，对尚存于世的人来说将有一段随之而来的痛苦

的适应期，其中包含丧亲和悲痛。丧亲（**bereavement**）是指对某个人死亡这一客观事实的承认和接受，而悲痛（**grief**）则是指对他人去世的一种情感反应。

悲痛的第一阶段通常伴随着震惊、麻木、质疑或完全否定。尽管痛苦一直存在，并相继引发悲痛、恐惧、深度悲伤和忧虑等情绪，但人们经常会回避客观事实，试图按照以往的方式继续生活。从某些方面来看，这种心理状态可能是有益的，因为它能帮助生者顺利地安排丧葬事宜并完成其他此刻在心理上感觉困难的任务。一般而言，人们会在几天或几周之内渡过这一阶段。

在悲痛的第二阶段，人们开始正视死亡，并意识到他们失去的程度。他们完全沉浸在巨大的悲痛之中，并开始承认自己将与死者永久分离的现实。哀悼者可能会陷入极度的悲伤甚至抑郁中，这也是此类情形中人们常会出现的情绪反应。他们可能会想念死去的亲人，情绪表现逐渐从不耐烦转到没精打采。然而，此时他们也开始重新审视自己与死者的实际关系，无论曾经是很好还是很糟。通过这种方式，他们会逐渐从与至爱亲人的痛苦联结中解脱出来（de Vries et al., 1997; Norton & Gino, 2014）。

悲痛的第三阶段是适应阶段。丧失亲人的生者将重拾对生活的信心并重新建立新的同一性身份，比如失去丈夫的女性把自己定位成单身者而不是寡妇，尽管这么做可能会让她们感受到强烈的悲痛。

在第四阶段，绝大多数人都能从悲痛中走出来，开始新的生活。他们会与旁人建立新的关系，有些人甚至发现应对死亡的经历激发了他们的自我成长。他们变得更加自立，更加懂得珍惜生活。

不过要记住，并非每个人都会以同样的方式或顺序渡过悲伤时期。人们在这个过程中表现出的巨大个体差异，主要原因在于他们的人格特点、与死者的关系或是丧亲后独立生活的可能性等。

实际上，多数经历丧亲之痛的人都有相当好的心理韧性，即便在所爱之人过世之后，他们也还是能很快体验到快乐等强烈的正性情绪。心理学家乔治·博南诺（George Bonanno）对丧亲所做的大量研究表明，从进化的角度来说，人类能够顺利应对丧亲带来的痛苦，并在那之后继续好好生活。他并不认为哀悼有固定的阶段，并认为多数人都可以在丧亲之后继续正常的生活（Bonanno, 2009; Mancini & Bonanno, 2012; McCoyd & Walter, 2016）。



在亲人或朋友死亡以后，人们都会经历一个痛苦的丧亲和悲痛过程。图中的这些人正在为一位死于敌人炮击的朋友默哀。

区分过分悲痛和正常悲痛 尽管社会对区分过分悲痛与正常悲痛有很多参考标准，但更细致的研究表明，这些假设大都不正确。悲痛持续的时间长短并没有特定的限制，尤其是那种“悲伤应该在配偶死亡一年后结束”的说法更是无稽之谈。

对有些人来说，沉浸在丧亲悲痛的时间可能要比一年长得多。有些人会经历复杂性悲痛（complicated grief），有时也叫作持续悲痛障碍（prolonged grief disorder），这是一种持续数月乃至数年都无法止息的悲伤。大约有15%的人在丧亲后会体验到复杂性悲痛（Piper et al., 2009; Schumer, 2009; Zisook & Shear, 2009）。

而另一些人可能会表现出不完全悲痛（incomplete grief），这是一

种个体在亲人去世后始终挥之不去的悲痛形式，它是由人们在丧亲后无法有效悲痛造成的。人们在当时可能没有意识到他们真实的痛苦，抑或缺乏悲痛的社会“许可”。例如，一个没有向父母坦承性取向的同性恋青少年在遭遇恋人的死亡后可能会被迫隐藏他的悲痛。而他们无法表达自己的悲痛，只会让其悲痛的过程愈加痛苦。

研究同样推翻了“丧亲会带来普遍的抑郁”这一观点，只有15%~30%的人在丧亲后会表现出相对严重的抑郁（Bonanno et al., 2002; Hensley, 2006）。

同样，人们通常认为在最初面对亲人死亡时没有表现出悲痛的人是不愿正视现实，在其后的日子里，他们更可能出现心理问题。但事实并非如此，那些在丧亲后即刻表现出抑郁的人随后最容易遇到健康和适应性问题（Boerner, Wortman, & Bonanno, 2005）

丧亲和悲痛的后果 在某种意义上，死亡是具“传染性”的，许多证据表明，寡居个体存在很大的死亡风险。一些研究表明，在丧偶后的第一年，个体死亡的风险是正常状态下的7倍，其中丧偶男性和丧偶年轻女性的死亡风险最大。再婚可以降低他们的死亡风险，对丧偶男性尤其有效，尽管暂时还未找到具体原因（Martikainen & Valkonen, 1996; Aiken, 2000）。

如果一个人本身就常常表现出不安、焦虑或恐惧的状态，那么丧亲更可能导致他们产生抑郁或其他负性结果，这也增加了他们寻求有效应对手段的难度。此外，与一直和死者关系稳定的人相比，与死者生前关系不稳定的人在死者去世后可能会受到更大的负面影响。那些高度依赖死者的亲人更容易在亲人亡故后陷入困境，同样的情形也会发生在那些过分悲痛的人身上。

如果缺乏来自家庭、朋友或其他团体等方面的社会支持，丧亲之人就更可能会觉得孤独，也因此面临更高的死亡风险。最终，无法为死亡赋予意义——比如感激生命的个体，会表现出更差的适应能力（Nolen-